金色机遇，构筑未来

——多维度视角下中国养老地产 CCRC 模式发展洞察与前景展望

队伍名称 宇宙最爱银发经济队

团队成员 吴湘 马诗云 李昱炫 顾彤彤

摘 要

在人口老龄化背景下，银发经济蓬勃发展，与传统房地产行业紧密结合的养老地产也成为新的热点。但在我国，养老地产尚属于发展初期，产业发展前景尚待进一步探索。养老地产能否适应我国养老服务市场生态？养老地产能否使得建房地产行业焕发新的生机，进而为经济带来新的增长点？养老地产是否适应我国老年人的服务需求？这些问题都亟待探索。因此，我们采用了从宏观到中观再到微观的分析框架，采取了质性分析和实证分析的分析方法，来探索我国养老地产的发展现状，并对我国养老地产行业的发展提出未来展望和建议。

第一部分我们从宏观的角度分析了养老地产发展的机会和挑战。从**人口结构的变化、银发经济市场的变化、房地产市场变化**等角度出发，提出发展养老地产是顺应时代需要的选择，为下文的多角度分析奠定了基础。

第二部分我们从中观的角度详细的分析国内外养老地产行业的发展情况。我们通过 **PEST 分析**，评估了政治、经济、社会和技术四个维度因素对养老地产行业的影响。接着，对养老地产的**产业链**进行了详细分析，探讨了养老地产的分类、行业全景、产业链分工，并对比了国内外养老地产的发展情况，尝试提出我国养老地产目前的发展痛点。

第三部分我们从微观的角度出发，选取了在世界范围内发展成熟并且在我国具备一定适配性的 **CCRC 模式**。首先介绍了该模式的运作模式和优势特点，进一步选取该模式下的先进案例——泰康之家，深入分析其商业模式和财务状况，也使用 **SWOT 分析**指出了泰康之家在我国发展的优势、劣势、机会和挑战。

第四部分我们使用**实证分析**的方法，探究影响老年人选择养老方式的因素和养老机构价格的影响因素。这一部分既回应了上文中提到的养老地产发展限制因素，也为最后一部分的建议提供了启发。

第五部分我们立足全局给出了养老地产行业的发展建议。与上述分析框架相契合，本部分从微观、中观、宏观三个层面分别为养老地产开发商、养老服务行业、政府政策治理提供了发展建议，并对中国养老地产的未来发展作出展望。

关键词：养老地产　CCRC 模式　房地产市场　养老服务供需适配

研究思路


背景分析
人口结构变化：人口老龄化加速发展
银发经济市场变化：供需矛盾日益凸显
房地产市场变化：总体进入疲软态势
发展养老产业顺应时代需要
行业分析
宏观PEST分析
政治：政策提供总体要求、指导与支持
经济：房地产下行但养老服务需求增加
社会：家庭养老面临挑战且养老观念转变
技术：新兴技术应用与医养结合推广
发展养老地产具有必要性和可行性
产业链分析
+
国外发展情况
+
国内发展情况
地区分布不均
空置率较高
投资市场不完善
供给市场两极分化
盈利模式和运营模式不成熟
行业痛点
案例分析
CCRC模式介绍
运作模式
服务对象
服务内容
运营模式
优势特点
一站式服务
熟悉环境
医养结合
社区支持
集中管理
CCRC模式在我国具有一定适配性
案例分析：泰康之家
商业模式
产品模式
服务模式
收费模式
销售模式
盈利模式
智慧模式
财务分析
具体案例介绍
机构案例
客户案例
波特价值链模型
优势
劣势
机会
挑战
SWOT综合分析
宏观实证
探究老年人机构养老方式选择的影响因素
行动能力
婚姻状况
户口性质
家庭人均收入
地区人均财政支出
+
探究养老机构的价格影响因素
CCRC模式
智慧养老
床位数量
养老机构性质
机构所在地区
医保资格
展望建议
宏观层面
政策支持
监管治理
宣传引导
中观层面
产业融合
市场细分
微观层面
拓宽融资
优化运营
复合产品

内容目录

摘 要 1
一、 背景分析 1
1.1 人口结构变化：人口老龄化加速发展 4
1.1.1 人口老龄化特点 4
1.1.2 人口老龄化原因分析 8
1.1.3 人口老龄化影响分析 9
1.2 银发经济市场变化：供需矛盾日益凸显 9
1.2.1 政策背景 10
1.2.2 养老需求增量演进，亟待供给体系响应要求 10
1.2.3 养老服务需求层次多样化 14
1.2.4 养老服务供给侧机遇挑战并存：需求匹配尚待优化 19
1.2.5 养老服务供给多元化：产业细分与百花齐放 20
1.2.6 养老服务供需矛盾凸显：银发经济市场潜力亟待释放 21
1.3 房地产市场变化：总体进入疲软态势 22
1.3.1 房地产市场下行的特点 22
1.3.2 房地产市场下行的成因分析 26
1.3.3 房地产市场发展进入转型时期 28
二、行业分析 30
2.1 养老地产行业 PEST 分析 30
2.1.1 政治环境：相关政策提供总体要求、指导与支持 30
2.1.2 经济环境：房地产市场下行但养老服务需求增加 31
2.1.3 社会环境：传统家庭养老面临挑战叠加养老观念发生转变 32
2.1.4 技术环境：新兴技术应用与医养结合推广 33
2.2 发展养老地产行业的必要性和可行性 33
2.3 行业产业链分析 34
2.3.1 行业全景 34
2.3.2 产业链分析 35
2.4 国外发展情况 39

2.4.1 美国——成熟的资本化多元养老体系 39
2.4.2 日本——政府支持下的标准化服务 41
2.4.3 国外养老地产发展经验总结 42
2.5 国内发展情况 43
2.5.1 我国养老地产的模式 43
2.5.2 我国养老地产的投资模式 46
2.5.3 我国养老地产的盈利模式 46
2.5.4 我国养老地产的投资主体 48
2.6 行业目前的痛点 51
2.6.1 地区分布不均 51
2.6.2 空置率较高 51
2.6.3 投资市场不完善 52
2.6.4 供给市场两极分化 52
2.6.5 盈利模式和运营模式不成熟 53
三、案例分析 54
3.1 CCRC 模式介绍 54
3.1.1 运作模式 54
3.1.2 CCRC 模式在我国的适用性与优势 56
3.1.3 CCRC 模式在我国可能面临的挑战 57
3.2 案例分析：泰康之家 58
3.2.1 公司简介 58
3.2.2 商业模式 59
3.2.3 财务分析 68
3.2.4 SWOT 综合分析 69
四、实证分析 76
4.1 老年人机构养老方式选择的影响因素 76
4.1.1 数据来源 76
4.1.2 数据描述 76
4.1.3 研究方法和模型设定 77
4.1.4 实证结果及分析 78
4.1.5 总结与结论 81

4.2 探究养老机构的价格影响因素 81
4.2.1 数据介绍 81
4.2.2 数据描述 81
4.2.3 相关性分析 82
4.2.4 养老机构价格影响因素分析 83
4.2.5 总结与结论 84
五、发展建议与展望 85
5.1 微观层面 85
5.1.1 创新融资方式，稳定资金来源 85
5.1.2 探索新型经营模式，实现可持续运作 85
5.1.3 开发复合产品，提供智能化高质量服务 85
5.2 中观层面 85
5.2.1 促进产业融合发展，深化合作关系 85
5.2.2 细分行业市场，形成多层次布局 86
5.3 宏观层面 86
5.3.1 优化政策环境，刺激行业供需发展 86
5.3.2 加大监管力度，建设行业标准 86
5.3.3 积极推广宣传，营造社会化养老氛围 87
参考文献 88

表目录

表 1 国际老龄化划分标准 4
表 2 养老地产的分类 35
表 3 中国养老地产主要开发商分类 36
表 4 中国养老产业代表性且关键指标对比（单位：个） 39
表 5 我国养老地产模式 43
表 6 房屋出售模式养老地产 44
表 7 我国大型险企投资养老地产概括 49
表 8 部分房地产开发企业养老品牌 50
表 9 跨界布局养老地产业务 50
表 10 补贴养老机构收费对比 53
表 11 CCRC 模式功能分区介绍 55
表 12 CCRC 模式的盈利模式 56
表 13 泰康之家各项目情况 62
表 14 变量的定义与描述性统计 77
表 15 实证结果 79
表 16 稳健性检验 80
表 17 描述性统计分析 82
表 18 相关性分析 82
表 19 回归分析 84

图目录

图 1 2013 年-2023 年全国 60 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重 5
图 2 2013 年-2023 年全国 65 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重 5
图 3 中、美、法、日、德、韩、英 7 国从老龄化到深度老龄化所用时间.....6
图 4 银发经济细分事业和产业图谱 7
图 5 不同省份/直辖市/自治区的人口老龄化情况 8
图 6 人口老龄化原因分析 8
图 7 人口老龄化影响分析.....9
图 8 我国城乡老年人消费支出结构变化情况.....10
图 9 2021 年中国老龄化率超过全球平均水平.....11
图 10 我国银发群体财富总量较大.....12
图 11 我国银发群体负债参与率较低.....12
图 12 中国老年人市场规模.....12
图 13 中国老龄化群体家庭月收入结构.....12
图 14 中国老年人参与休闲活动率.....12
图 15 中国老年人劳动参与率逐年上升.....13
图 16 中国老年人就业率变动情况.....13
图 17 中国历年人均预期寿命演变.....14
图 18 马斯洛需求层次与中国老年人养老需求多样化.....14
图 19 老年人养老需求的具象分类.....15
图 20 中国各地区 60 岁及以上人口占比分布.....16
图 21 中国老年人经济来源占比.....16
图 22 中国老年人健康状况.....17
图 23 中国老年人居住安排.....17
图 24 中国老年人养老模式划分.....18
图 25 京沪市场 CCRC 养老社区入住率表现较好.....18
图 26 2017-2023 养老床位与 65 岁以上老年人数及增速对比 19
图 27 2014-2021 年每千 65 岁以上养老供给量不及老龄化加速下的需求量.....20
图 28 2013-2023 年全国房地产开发企业个数及其增长率.....23
图 29 2013-2023 年房地产开发企业购置土地面积和土地成交价款及其增长率.....23

图 30 2013-2023 年全国新建商品住宅开发投资完成额和新开工商品住宅面积及其增长率 24
图 31 2013-2023 年全国住宅销售套数及其增长率 25
图 32 2013-2023 年全国新建商品住宅销售面积和销售金额及其增长率 25
图 33 2018-2021 年全国房地产债务违约情况 27
图 34 房地产发展恶性循环图 27
图 35 四大地产商业模式 29
图 36 养老地产行业 PEST 分析 30
图 37 2019 年-2023 年国内生产总值及其增长速度 32
图 38 老年人群及中年人群未来想选择的养老方式 33
图 39 养老房地产行业全景 34
图 40 养老行业产业链 35
图 41 按照市场角色划分养老地产产业链 37
图 42 养老地产行业产业链 38
图 43 美国养老地产行业多样化发展 40
图 44 物业企业开展养老业务模式 44
图 45 度假式养老地产模式 45
图 46 我国养老地产模式 46
图 47 养老地产中期盈利模式 47
图 48 养老地产成熟期盈利模式 48
图 49 我国各路资本布局养老地产 48
图 50 我国养老地产分布 51
图 51 全国四大养老地产聚集区养老地产平均售价 52
图 52 CCRC 运作模式图 54
图 53 唐康品牌标志 58
图 54 泰康之家全国布局情况 59
图 55 泰康之家在泰康集团商业模式中的地位 60
图 56 泰康之家商业模式的波特价值链框架 60
图 57 以自建医院为依托的 CCRC 持续照料退休社区 61
图 58 泰康之家康养融合模式 64
图 59 1+N 服务团队服务模式 64

图 60 泰康之家三大服务体系 65
图 61 泰康之家分级护理 65
图 62 泰康之家智慧护理 66
图 63 泰康集团医疗、养老社区及纪念园收入/成本分析 68
图 64 泰康之家的 SWOT 分析 69

一、背景分析

1.1 人口结构变化：人口老龄化加速发展

人口老龄化是涉及人口结构变化的概念，指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。国际上通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准，当一个国家或地区 60 岁及以上老年人口占人口总数的 10%，或 65 岁及以上老年人口占人口总数的 7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

表 1 国际老龄化划分标准

国际老龄化划分标准	
65 岁及以上人口占总人口比例	老龄化程度
7%-14%	老龄化社会
14%-20%	深度老龄化社会
超过 20%	超老龄化社会

来源：公开资料

目前，伴随着人口寿命的延长与生育率的下降，全球范围内的人口老龄化正加速发展。2001 年，60 岁及以上老年人口比例首次达到 10%，标志着全球正式进入老龄化社会；2023 年，这一比例已经上升至 14.2%。根据联合国发布的《世界人口展望 2024》，到 2070 年代末，全球 65 岁及以上的人口预计将达到 22 亿人，超过 18 岁以下的儿童人数。

人口老龄化亦是我国社会经济发展的重要特征，且相比较全球水平，我国人口老龄化问题更为凸显。**据国家统计局数据显示，截至 2023 年年底，中国 60 岁及以上老年人口总量已达到 2.96 亿人，占总人口的 21.1%，65 岁及以上人口占比 15.4%，这意味着我国已由老龄化社会迈入深度老龄化社会。**

1.1.1 人口老龄化特点

我国的人口老龄化主要有老年人口规模庞大、人口老龄化速度快、老龄人口代际差异显著、未富先老和未备先老、城乡差异和地区差异显著五方面的特点。

（1）老年人口规模庞大

截至 2023 年年底，中国 60 岁及以上老年人口总量已达到 2.96 亿。根据联合国发布的《世界人口展望 2022》数据，我国老年人口规模占全球老年人口规模

的 1/4 左右。2020 年，我国 80 岁及以上的高龄老年人口规模占世界高龄老年人口规模的 23.6%。在未来五十年内，我国都将是世界上老年人口最多的国家。

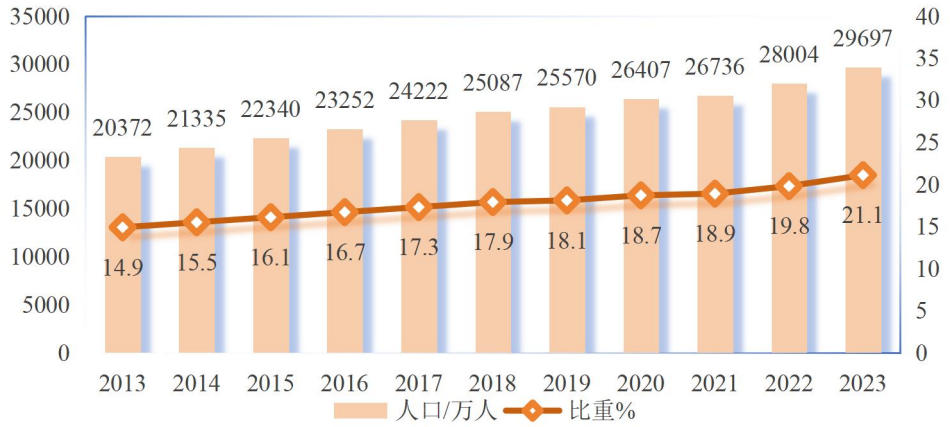


图 1 2013 年-2023 年全国 60 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

来源：民政部《2023 年度国家老龄事业发展公报》

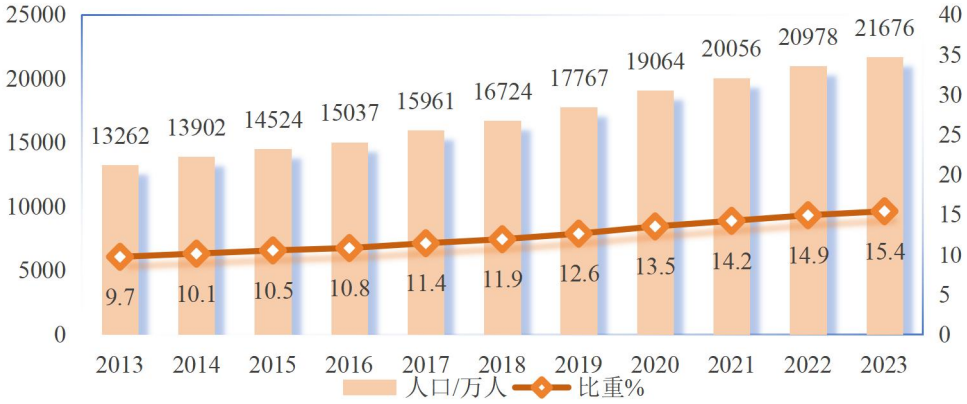


图 2 2013 年-2023 年全国 65 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

来源：民政部《2023 年度国家老龄事业发展公报》

（2）人口老龄化速度快

从老龄化速度看，我国的老龄化速度在全球范围内居于较高水平。从 65 岁及以上老龄人口占比超过 7%的老龄化过渡到超 14%的深度老龄化，我国仅用了 21 年，远快于欧美国家。而根据联合国预测，我国从深度老龄化进入超老龄化可能仅需要 9 年左右的时间。快速发展的老龄化带来了社会经济结构的巨变，也将对养老产业提出更为紧迫的需求。

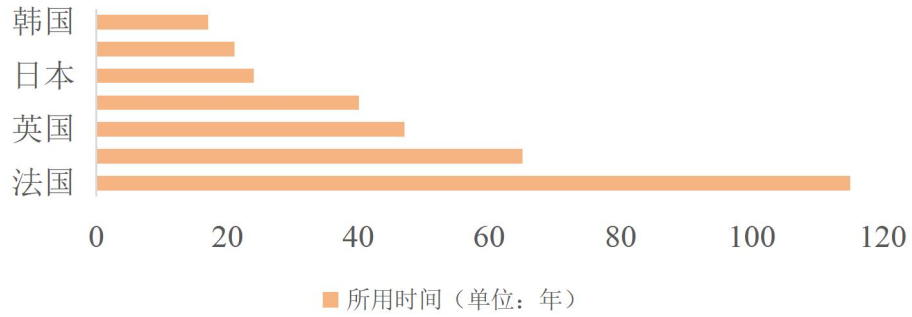


图 3 中、美、法、日、德、韩、英 7 国从老龄化到深度老龄化所用时间

来源：公开资料

（3）老龄人口高度异质性，代际差异显著

新中国成立以来，我国在政治、经济、社会等层面发生了翻天覆地的变化，不同出生年代的人群在教育文化程度、财富积累、消费习惯、需求偏好等行为特征方面具有高度的异质性。

70 岁及以上老年人出生于新中国成立前后，成长于物质较为匮乏的年代，并在社会保障制度尚不健全的阶段进入老年期，具有节俭和实用型的消费习惯，需求也多为基本的养老服务需求，如基本医疗、基本养老保险等。

60-69 岁的老年人是我国老龄人口的主体，与改革开放同步发展，享受到经济发展和社会保障体系不断完善的时代红利，往往具有更多的文化休闲娱乐等方面的需求。

60 岁以下的年长工作者是潜在的老龄人口，其职业生涯阶段与经济高速增长和信息技术迅速发展密切相关，同时其往往具有更高的受教育水平，因而这一群体在退休后往往具有较强的自我发展和提升的需求。

基于代际差异产生了多元化、多层次的养老服务需求，这对我国养老产业的发展提出了新的要求和挑战。下图呈现了不同年龄阶段老年群体的个性化需求及对应的银发经济产业：

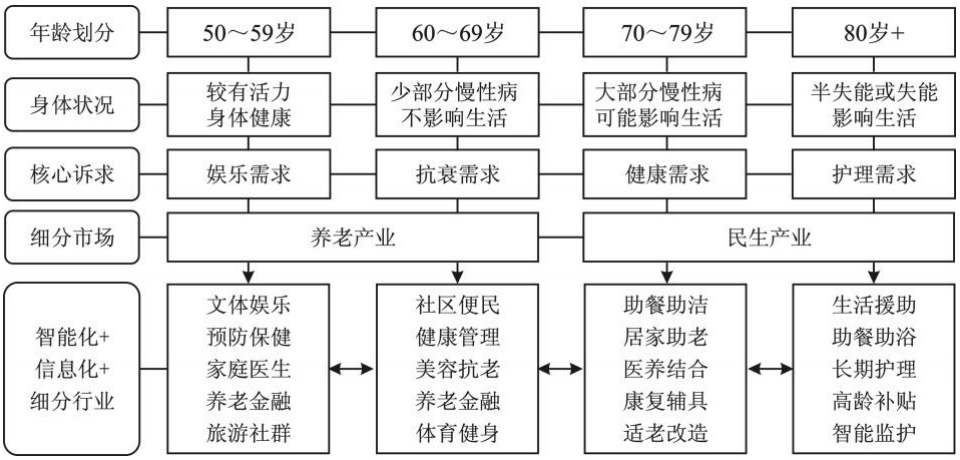


图 4 银发经济细分事业和产业图谱

来源：金牛，刘梦琦 《银发经济高质量发展：内涵意蕴、机遇挑战与体系构建》

（4）未富先老和未备先老

我国经济发展尚处于薄弱状态，呈现出“未富先老”的特征。同时，由于现有养老体系并不完善、养老产业尚待发展，呈现出“未备先老”的特征。在未来一段时间内，中国既要面临经济发展的问题，又要保障老龄人口的养老问题。

（5）城乡差异和地区差异显著

从城乡视角看，受劳动力流动的影响，农村老龄化程度显著高于城市。第七次全国人口普查数据显示，2020 年农村 60 岁及以上老年人口占农村地区总人口比重为 23.81%，比城镇高近 8 个百分点。

从区域视角看，第七次全国人口普查显示，东北、川渝、长三角等地区的人口老龄化程度较高。下图详细呈现了不同省份/直辖市/自治区的人口老龄化情况：

单位：万人，%　　(10000 persons,%)

地区 Region	人口数 Population	年龄别人口 Population by Age Group			比重 Proportion		
		0-14	15-64	65+	0-14	15-64	65+
总计 Total	141178	25338	96776	19064	17.95	68.55	13.50
北京 Beijing	2189	259	1639	291	11.84	74.86	13.30
天津 Tianjin	1387	187	995	205	13.47	71.77	14.75
河北 Hebei	7461	1509	4913	1039	20.22	65.85	13.92
山西 Shanxi	3492	571	2470	450	16.35	70.74	12.90
内蒙古 Inner Mongolia	2405	338	1753	314	14.04	72.90	13.05
辽宁 Liaoning	4259	474	3044	742	11.12	71.46	17.42
吉林 Jilin	2407	282	1750	376	11.71	72.68	15.61
黑龙江 Heilongjiang	3185	329	2359	497	10.32	74.07	15.61
上海 Shanghai	2487	244	1839	405	9.80	73.92	16.28
江苏 Jiangsu	8475	1289	5813	1373	15.21	68.59	16.20
浙江 Zhejiang	6457	868	4732	857	13.45	73.29	13.27
安徽 Anhui	6103	1174	4013	916	19.24	65.75	15.01
福建 Fujian	4154	803	2890	461	19.32	69.58	11.10
江西 Jiangxi	4519	992	2990	537	21.96	66.16	11.89
山东 Shandong	10153	1906	6710	1536	18.78	66.09	15.13
河南 Henan	9937	2299	6297	1340	23.14	63.38	13.49
湖北 Hubei	5775	942	3991	842	16.31	69.10	14.59
湖南 Hunan	6644	1297	4363	984	19.52	65.67	14.81
广东 Guangdong	12601	2375	9145	1081	18.85	72.57	8.58
广西 Guangxi	5013	1184	3217	611	23.63	64.18	12.20
海南 Hainan	1008	201	702	105	19.97	69.59	10.43
重庆 Chongqing	3205	510	2148	547	15.91	67.02	17.08
四川 Sichuan	8367	1347	5604	1417	16.10	66.97	16.93
贵州 Guizhou	3856	924	2486	446	23.97	64.48	11.56
云南 Yunnan	4721	924	3290	507	19.57	69.69	10.75
西藏 Tibet	365	89	255	21	24.53	69.80	5.67
陕西 Shaanxi	3953	685	2741	527	17.33	69.34	13.32
甘肃 Gansu	2502	485	1702	315	19.40	68.02	12.58
青海 Qinghai	592	123	418	51	20.81	70.51	8.68
宁夏 Ningxia	720	147	504	69	20.38	70.00	9.62
新疆 Xinjiang	2585	581	1804	201	22.46	69.78	7.76

图 5 不同省份/直辖市/自治区的人口老龄化情况

来源：2020 年第七次人口普查数据

1.1.2 人口老龄化原因分析

人口老龄化主要由两大方面的因素共同影响而成。第一，由于人口平均寿命延长导致老年人口比例增加；第二，由于人口出生率下降导致年轻人口比例减少。具体原因作用机制呈现于下图：

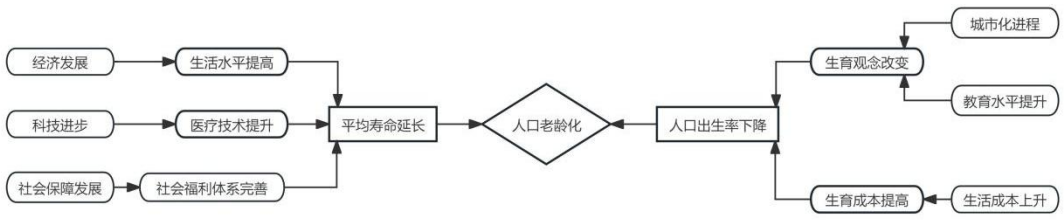


图 6 人口老龄化原因分析

来源：团队成员整理

1.1.3 人口老龄化影响分析

人口老龄化对于社会经济的发展具有双重影响。下图总结了人口老龄化的影响：

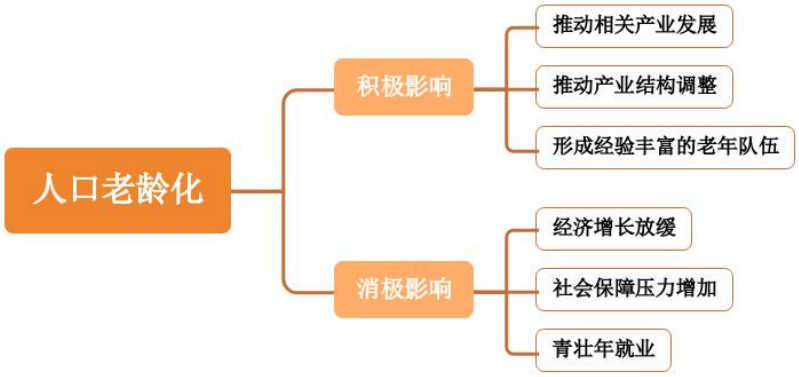


图 7 人口老龄化影响分析

来源：团队成员整理

一方面，**人口老龄化在滋生新需求并推动相关产业发展、推动产业结构调整、形成经验丰富的劳动队伍等方面具有积极影响**。庞大的老年人口带来新的养老服务需求，带动了养老服务、医疗健康、文娱旅游、养老金融等相关产业的发展。同时，人口老龄化增加了服务业的需求，为第三产业的发展提供了动力，推动了产业结构的调整与优化。此外，尽管许多达到退休年龄的老年人已经退出劳动力市场，但其具有相对丰富的工作经验和熟练的工作技能。推动老年人再就业，能够在为企业和社会创造更多价值的同时也促进老年人更好地融入社会。

另一方面，**人口老龄化也会带来经济增长放缓、社会保障压力增加、劳动力短缺等消极影响**。人口老龄化会导致劳动年龄人口减少、劳动力市场供给不足，可能会制约国家整体经济发展。与此同时，老年人口增加将给社会保障体系带来压力，已有的基本养老服务体系无法满足老年人群的需求。在此基础上，人口老龄化加速发展可能会影响劳动生产率，进而影响国家的经济增长。

1.2 银发经济市场变化：供需矛盾日益凸显

由上述分析可知，我国人口老龄化高速发展，并且老龄人口内部存在异质性，这对我国养老需求的构成以及服务供给的模式产生了显著影响。

1.2.1 政策背景

为积极应对人口老龄化的现状，我国颁布了一系列政策来推动银发经济的发展和养老服务设施的完善，多次明确要扩大养老服务供给，打造高质量养老服务和产品供给体系，推动养老多业态融合发展。部分重要政策如下图所示：

颁布时间	发文部门	文件名称	核心内容
2019 年	国务院	《国家积极应对人口老龄化中长期规划》	明确规划了我国积极应对老龄化的战略目标。规划明确指出，要打造高质量的养老服务和产品供给体系，推进健康中国建设，建立和完善老年健康服务体系，健全养老服务体系。
2019 年	民政部	《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》	提出要全方位优化养老服务的有效供给。
2021 年	国家发改委	《第十四个五年规划纲要和 2035 年远景目标纲要》	将养老服务体系的建设作为单独一节部署，并进一步细化了养老服务体系建设的目标，提出扩大养老机构护理型床位供给占比至 55%。
2021 年	国务院	《十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》	提出 2025 年的发展目标，包括养老服务供给的扩大、老年健康支撑体系的健全、为老服务多业态的创新融合发展、要素保障能力的持续增强以及社会环境的适老宜居化。
2022 年	国务院	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务事业规划》	提出到 2025 年，我国养老服务床位达到 900 万张以上，明确将养老服务床位数纳入“十四五”养老服务发展硬指标。
2024 年	国务院	《发展银发经济增进老年人福祉的意见》	提出要扩大养老产品供给，提升质量水平。

图 8 银发经济相关政策文件

资料来源：国务院、民政部等部门网站，团队成员整理

1.2.2 养老需求增量演进，亟待供给体系响应要求

（1）老年消费结构改变，有效需求层次拓宽

随着社会经济条件的改善，老年人的需求层次与结构已大为不同。2020 年，城乡老年人的消费支出中，日常消费、医疗健康、社交娱乐及养老金融的占比分别为 61%、22%、13%和 4%。与 2014 年相比，医疗健康与社交娱乐的支出占比分别显著增长了 8 个百分点和 10 个百分点，充分反映出老年人需求结构的变化。

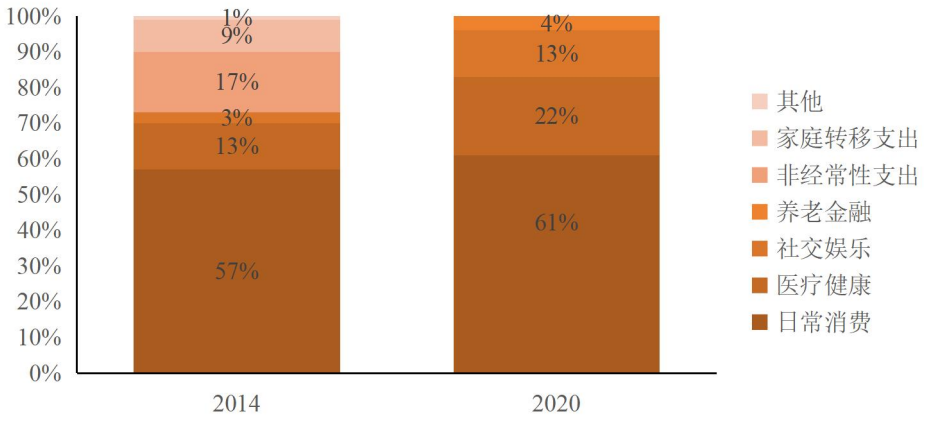


图 8 我国城乡老年人消费支出结构变化情况

数据来源：贝壳财经

（2）老年人口基数庞大，需求数量持续增长

老年人养老需求因其庞大的基数维持增长的态势。上文提到，我国 65 岁及以上人口占比远高于全球水平，为银发经济带来了巨大的市场潜力。

排名	国家/地区	2021 年 65 岁及以上人口占比（%）
1	摩纳哥	36
2	日本	29.8
3	意大利	23.7
4	芬兰	22.9
5	葡萄牙	22.6
6	希腊	22.5
7	保加利亚	22.4
8	波多黎各	22.4
9	德国	22.2
10	马恩岛	22
75	**中国**	**13.1**
平均水平	全球	9.6

图 9 2021 年中国老龄化率超过全球平均水平

来源：公开资料

（3）支付消费双增强，新老龄群体注入活力

随着社会的不断进步和经济的发展，老年人群体的支付能力和消费能力日益增强，呈现出充满活力的新老龄化特质。

首先，新老龄化群体拥有较强的支付能力，大多经历过改革开放的浪潮，享受着经济发展的红利，积累了较为可观的财富。根据中国人民银行发布的《2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》，65 岁及以上群体的家庭总资产达到了 288 万元，显示出老年人口巨大的财富积累和消费潜力；同时其家庭负债参与率在所有年龄阶段中占比最低，仅占 25.10%。

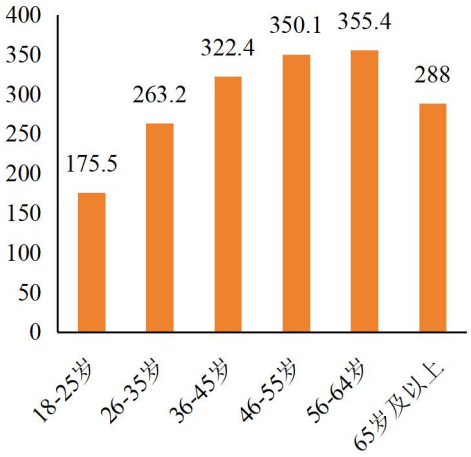


图 10 我国银发群体财富总量较大



图 11 我国银发群体负债参与率较低

来源：中国人民银行《2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》

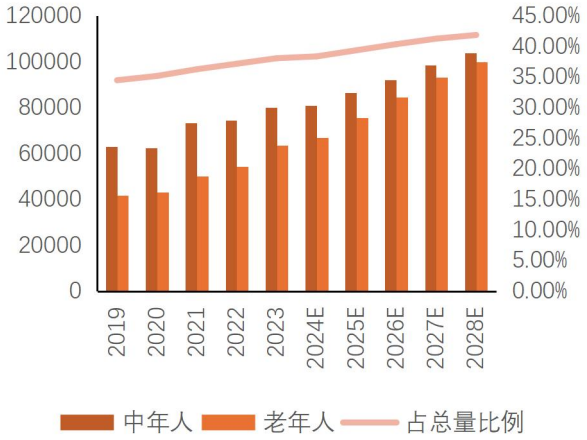


图 12 中国老年人市场规模

来源：公开数据

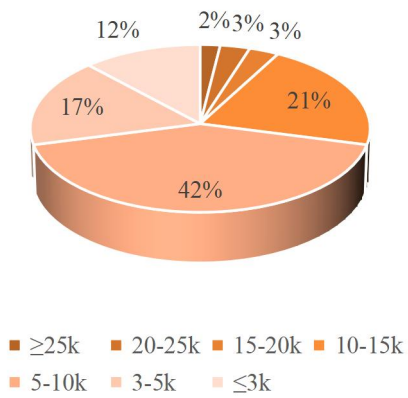


图 13 中国老龄化群体家庭月收入结构

来源：Wavemaker

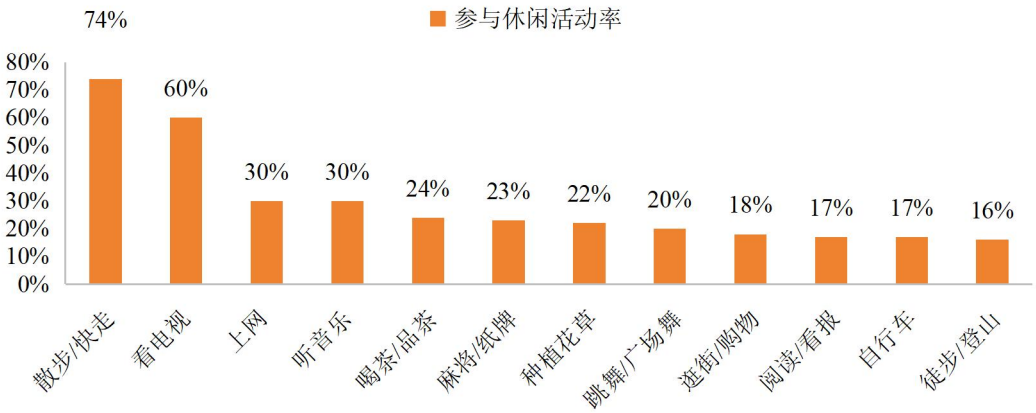


图 14 中国老年人参与休闲活动率

来源：Wavemaker

其次，老年人健康水平的提升和职业生涯的延长也进一步增强了其消费能力。随着医疗技术的进步和生活水平的提高，老年人的健康状况得到了显著改善，他们的职业生涯也因此得以延长。根据国家人口普查数据，老年劳动参与率随经济发展水平逐渐波动上升，老年人有更多的收入来源去支撑消费需求。

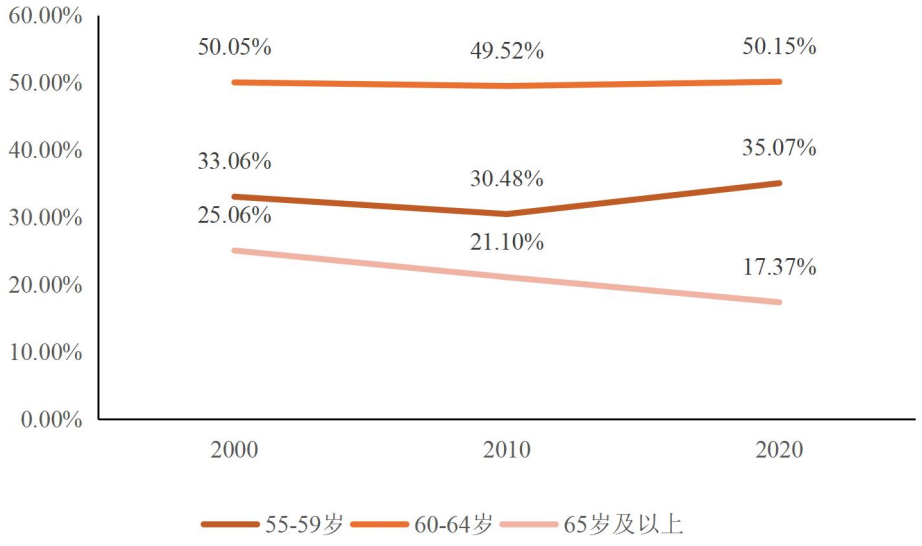


图 15 中国老年人劳动参与率逐年上升

数据来源：第五次、第六次和第七次全国人口普查分年龄段劳动参与率分布情况

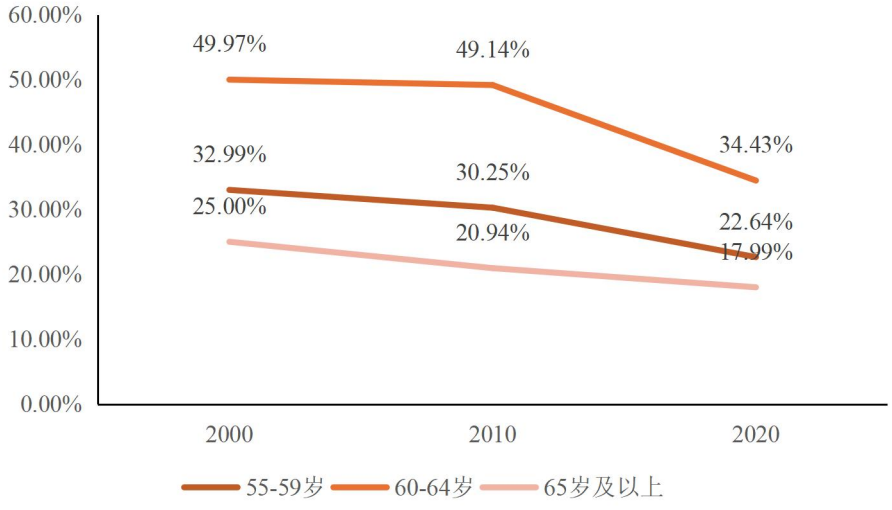


图 16 中国老年人就业率变动情况

数据来源：第五次、第六次和第七次全国人口普查分年龄段就业率分布情况

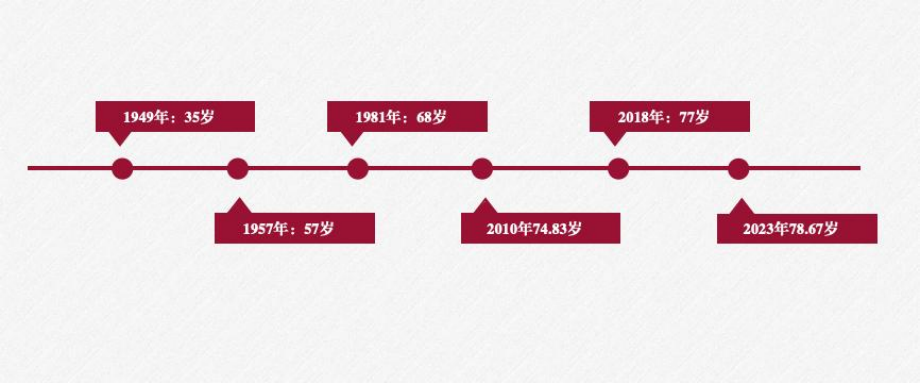


图 17 中国历年人均预期寿命演变

数据来源：国家统计局

1.2.3 养老服务需求层次多样化

随着我国老年人口的健康状况、经济状况、文化背景及生活方式的差异，其养老需求在马斯洛需求层次理论的基础上进一步细分，形成了多层次、多样化的需求体系，对养老服务产业的转型升级提出了新的要求。

（1）养老服务需求多元化特征

首先是基础生理与安全需求层次，包括“老有所养”和“老有所医”两个方面，即老年人对于基本生活保障和医疗保健的迫切需求，构成了老年人生活的稳固基石。

其次是精神文化需求层次，涵盖了“老有所乐”和“老有所学”两大领域，即老年人对精神文化生活、情感慰藉以及继续教育的渴望。

最后是社会参与与自我实现需求层次，主要体现在“老有所为”上，即老年人对于积极参与社会活动、发挥余热、实现自我价值的深切期望。

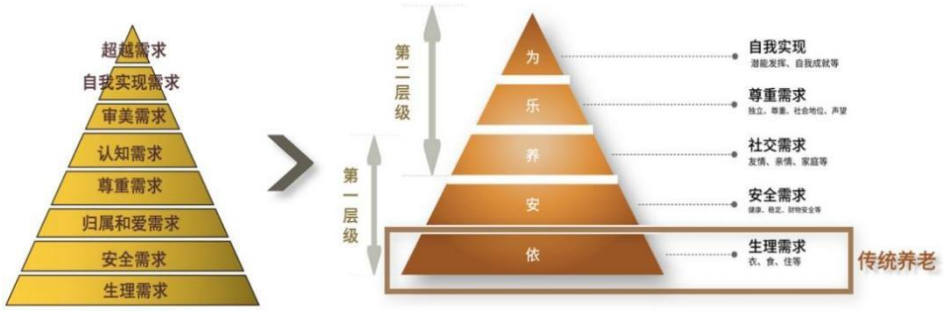


图 18 马斯洛需求层次与中国老年人养老需求多样化

数据来源：Maslow，Cosmin Munteanu & Albert Ali Salah

基于多维度分析，养老服务需求可被系统地划分为四大模块。首先，日常需求模块聚焦于老年人维持基本生活的必需品，如服饰、食品饮料、日常护理用品，确保老年人生活的舒适与便利。其次，保健需求模块着重于老年人的身体健康与疾病预防，通过提供营养保健品、医疗器械如轮椅、助听器和血压计，来管理老年人的健康状况。精神需求模块则关注老年人的心理健康与精神文化生活，通过组织旅游、提供教育、丰富的娱乐产品来丰富老年人的精神世界。最后，医养需求模块作为日常养护需求与医疗需求的结合体，强调在保障老年人基本养老的同时，也要关注其身体健康。

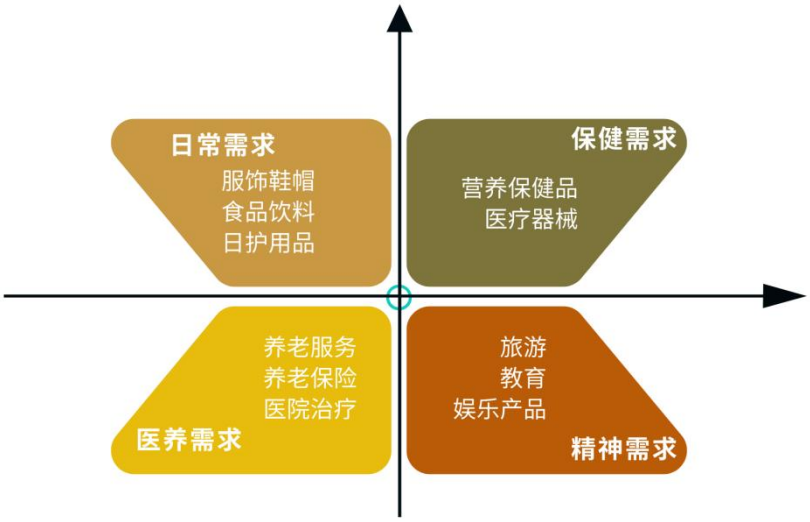


图 19 老年人养老需求的具象分类

数据来源：团队成员整理

（2）人口结构差异对养老服务需求的影响

1.地区差异

我国人口老龄化存在显著的地区差异。具体表现为东部地区的老龄化程度高于西部地区，一线城市高于二三线城市，农村高于城市。

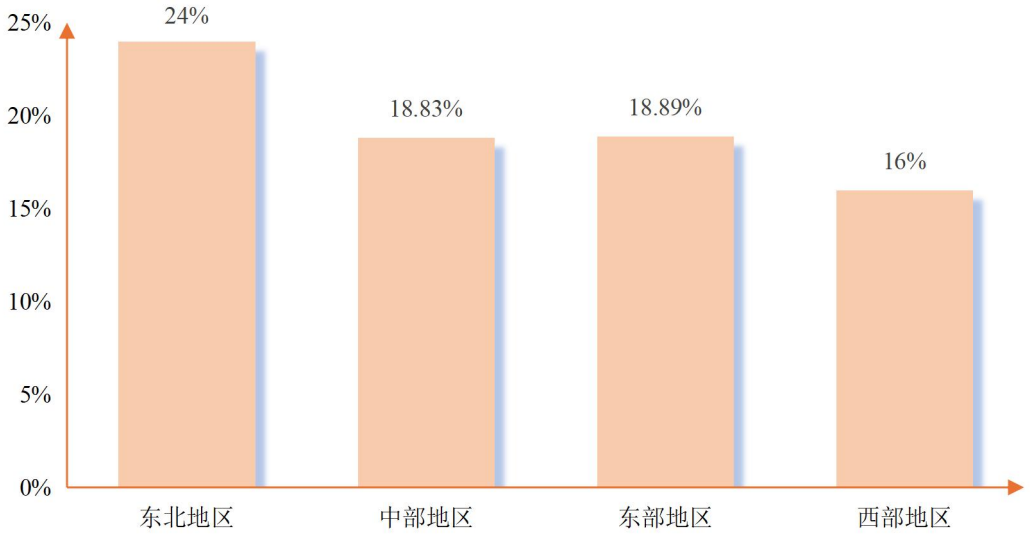


图 20 中国各地区 60 岁及以上人口占比分布

数据来源：国家统计局

2.购买力差异

老年人口的购买力水平直接影响其养老需求的满足程度。我国人均养老金水平偏低，且地域间存在显著的差异性，对老年群体的消费能力构成制约。

依据第七次全国人口普查，有 67%的老年人其主要经济来源为退休养老金及家庭成员的供养，依赖劳动所得、最低生活保障补助、失业保险金及财产性收入的老年人比例分别为 22%、4%及 1%。根据全国 31 个省级行政区人力资源和社会保障部门发布的统计数据，2022 年度省级养老金水平的差异性尤为突出，其中，2022 年西藏自治区的养老金水平位居首位，与处于末位的吉林省相比，二者之间存在 2437 元的显著差距。

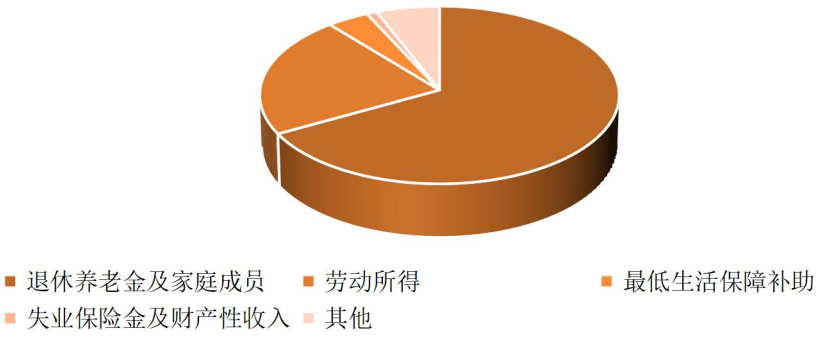


图 21 中国老年人经济来源占比

数据来源：国家统计局

3.不同出生队列的异质性与偏好

不同年代出生的人口，受宏观环境、科技革新、教育普及程度等多重因素影响，展现出鲜明的个性化特征。中国自 1949 年以来经历的三次“婴儿潮”驱动着银发经济向提供更加全面、专业、个性化的方向发展，旨在提升老年人的生活质量，确保其在晚年享有尊严与舒适。

4.对养老模式的异质性偏好

国家卫健委老龄健康司司长王海东指出，2021 年我国养老模式呈现出“9073”格局，即 90%的老年人偏好居家养老，7%选择社区养老，而仅有 3%倾向于机构养老。第七次全国人口普查数据显示，健康及基本健康的老年人占比达到 80%以上，与配偶或子女同住的老年人占比高达 83%，而选择入住养老机构的老年人仅占 0.73%，验证了这一现实。

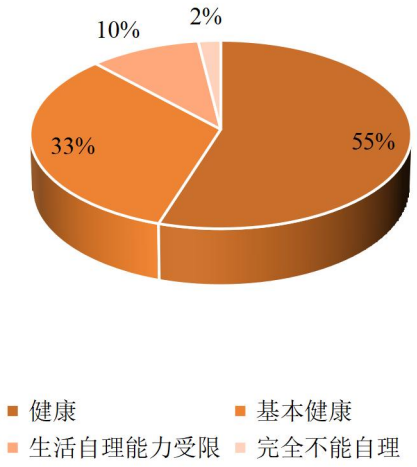


图 22 中国老年人健康状况

数据来源：国家统计局

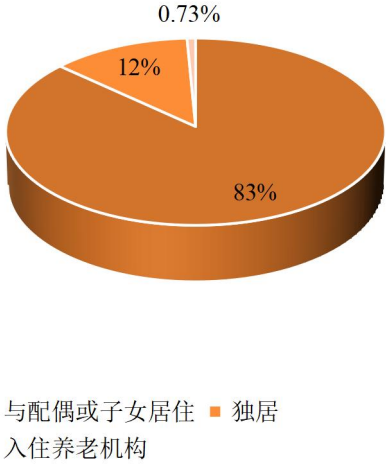


图 23 中国老年人居住安排

数据来源：国家统计局

进一步细分，社区养老模式可区分为传统社区与由房地产开发商专门打造的老年社区；机构养老则涵盖政府设立的社会福利院、敬老院，以及由社会力量兴办的老年公寓、老年康复中心、高端养护院等多种形态。此外，在传统养老模式的基础上，还涌现出诸如虚拟养老院、互助养老等新兴养老模式，进一步丰富了老年人的养老选择。

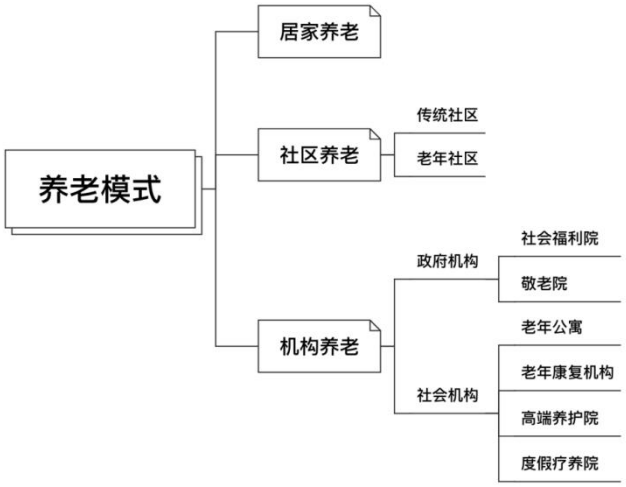


图 24 中国老年人养老模式划分

数据来源：公开资料

尽管，老年人的支付与消费能力在逐步增强，但在养老服务方面的需求却远未得到充分满足。居家养老作为我国主流的养老方式，其基础设施如养老驿站等供给严重不足，据国家卫健委数据显示，高达 90%的失能老年人选择居家养老却面临服务短缺。

同时，我国养老机构的运营状况分化明显，能力较弱的机构入住率持续下滑，而服务质量好的机构则入住率持续上升，CRIC 康养产业数据显示，整体养老机构床位入住率从 2017 年的 53.99%下滑至 2022 年的 43.22%。然而，高端市场化项目如 CCRC 养老社区和 CB（养老公寓）在京沪市场的入住率较高，且 2023 年入住率较 2022 年略有提升，显示出养老服务市场仍具有较大的发展潜力。

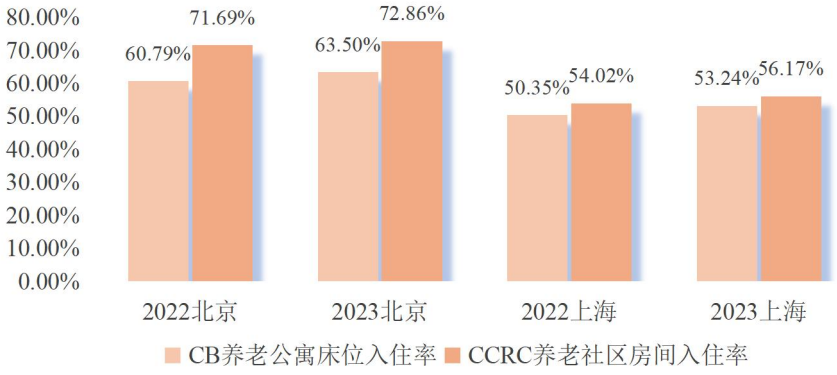


图 25 京沪市场 CCRC 养老社区入住率表现较好

数据来源：CRIC 康养产业数据

1.2.4 养老服务供给侧机遇挑战并存：需求匹配尚待优化

尽管银发经济拓宽老年消费选项，各领域产业已初具规模，但产品和服务同质化严重，整体品质尚待提升。

在传统社会中，由于老龄化水平相对较低，老年抚养比不高，且老年人劳动参与率高，家庭内部尚能满足老年人的养老需求。随着老年抚养比持续攀升，总抚养压力由降转升，且伴随女性劳动参与率的提升、护理专业化需求的增长、人口流动加速、家庭结构变化以及文化观念的转变，**家庭养老模式逐渐力不从心，养老服务供给的规模化与专业化成为必然趋势。**

近年来，国内养老服务供给迅速增加。据《中国与亚太发达国家银发经济比较研究》显示，截至 2022 年，中国已有近 25 万家企业涉足养老领域，银发产业规模达到 5.4 万亿元，同比增长 25.58%。尽管供给量快速增长，但相较于老龄化加速下的需求增长，养老服务供给仍存在明显缺口。

从全国 2017-2023 年养老床位与 65 岁以上老年人数及增速对比来看，养老机构床位数量在 2018 年、2021 年、2023 年均出现了负增长。与 65 岁以上老年人口数量增速相比，养老机构床位数量增速基本落后于老年人口增速，表明老年服务供给市场整体发展较为缓慢，滞后于我国老龄化发展速度。

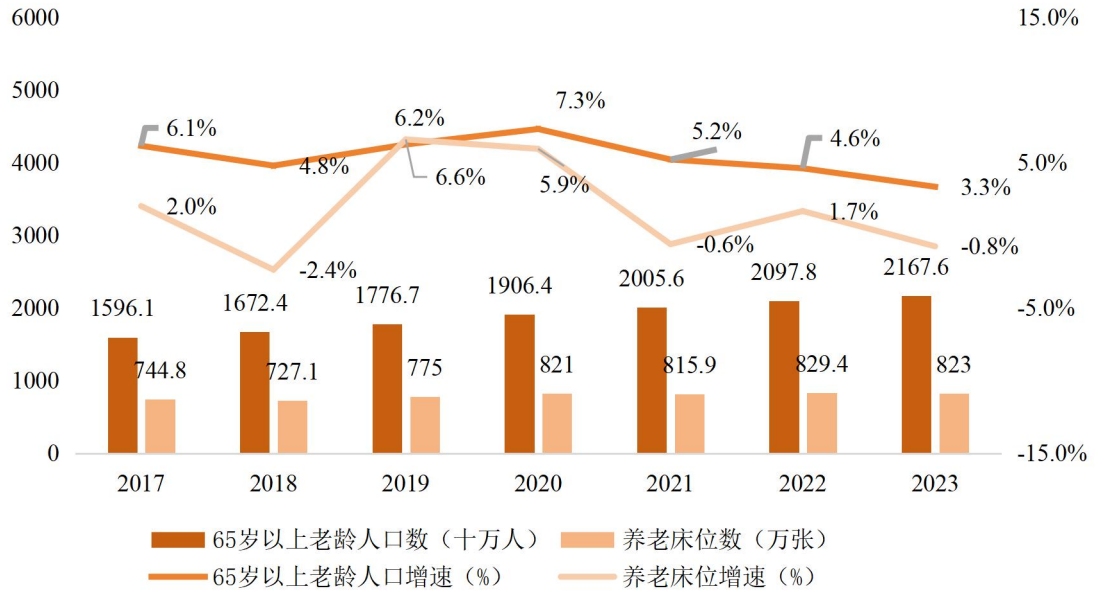


图 26 2017-2023 养老床位与 65 岁以上老年人数及增速对比

数据来源：国家统计局、民政部

从省域层面看，2014-2021 年每千 65 岁及以上老年人的养老机构和床位数量并未随需求增长而同步增加，反而出现下降趋势。这表明，现有养老服务供给增速仍低于需求增速，而多层次、多样化的养老需求则面临更大的供给挑战。

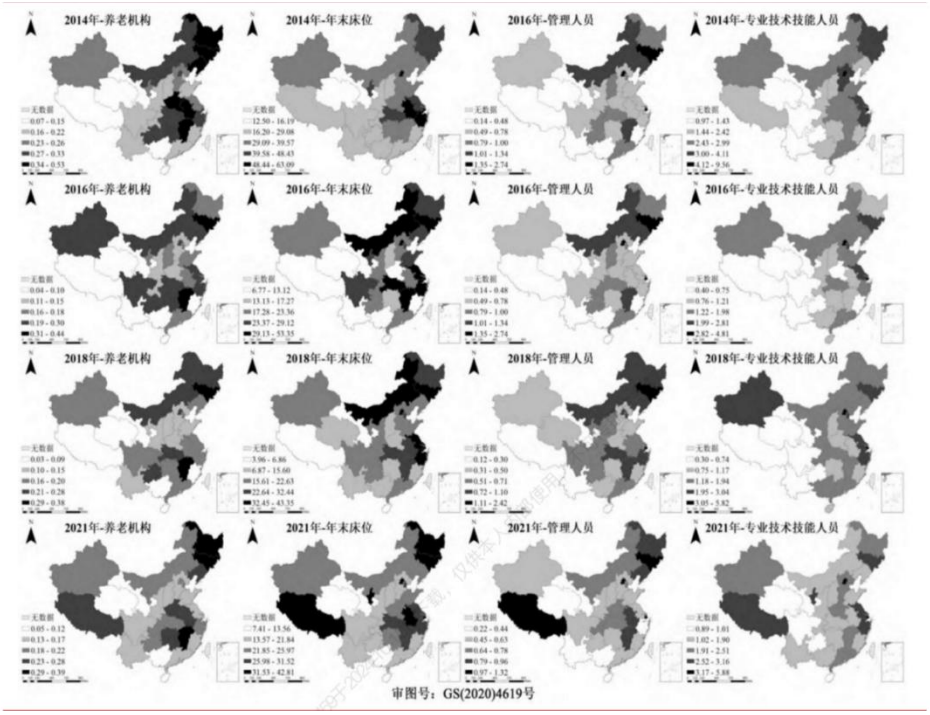


图 27 2014-2021 年每千 65 岁以上养老供给量不及老龄化加速下的需求量

来源：郭珊珊等《我国养老机构资源配置时空差异分析与优化策略——基于 2014-2021 的国家统计数据》

1.2.5 养老服务供给多元化：产业细分与百花齐放

根据《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》的指导，我国银发经济已初步形成了涵盖养老设施、养老服务、老年用品、智慧健康、文化旅游以及养老金融在内的六大领域。

在老年餐饮服务体系构建方面，上海、北京等一线城市已取得较为突出的实践成果。上海作为老龄化程度较高的代表性城市，截至 2022 年底，已成功布局 1608 个社区老年餐饮服务站，日均服务老年群体达 16 万人次，有效缓解了老年人就餐难题。

在老年健康服务范畴内，参考《2021 年中国卫生健康事业发展统计公报》、《2022 年世界卫生统计报告》及《2022 年中国卫生健康统计年鉴》的数据，我国居民平均带病生存期约为 9.7 年。鉴于此，众多公立医院及社区卫生服务机构正不断强化其在老年疾病诊断、康复治疗及照护服务等方面的专业能力，以期持

续提升服务质量。

养老照护服务同样呈现多样化发展。市场上已涌现出医护到家、一号护工等便捷的上门服务机构，以及九如城、福寿康等知名床位机构。养老床位主要分为普通型和护理型，其中护理型床位由具备专业护理能力的机构提供。然而，当前养老机构的盈利能力普遍较弱，2021 年实现盈利、收支平衡和亏损的机构占比分别为 6.4%、67.5%和 26.1%。

农村养老服务领域也在逐步发展。近年来，得益于缩小城乡医疗卫生资源差距的政策扶持，农村床位数和卫生技术人员增长率明显高于城市，但绝对值上仍存在较大差距。

1.2.6 养老服务供需矛盾凸显：银发经济市场潜力亟待释放

（1）供给市场准备不足，商业模式不成熟

我国商业养老服务市场尚处于探索期，服务提供的数量和质量都与当下的服务需求存在一定的差异。以养老照护市场为例，大中型企业主要问题是前期投资成本大，回报周期长，小型企业则主要依赖国家补贴生存，盈利空间也较为薄弱。因此，与连年增长的养老需求相比，商业养老供给缺乏资本投入，供给增长速度落后于老龄化发展速度。

（2）缺乏示范企业，供给同质化

当前我国商业养老市场以中小型企业为主，还未出现较为强势的龙头企业。民政部中国养老机构数据显示，在 58000 个养老机构当中，床位数量超过 500 张的养老机构总数仅占不到总数的 2%。缺乏龙头企业的示范作用导致市场养老服务产品缺乏创新，呈现同质化的趋势，难以满足老年人多元化的需求，也难以形成差异化竞争的格局。同时，市场供给缺乏统一规范，导致部分企业供给质量低下，不利于养老服务质量整体水平的提升。

（3）养老服务从业人员数量紧缺

第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，目前我国失能老年人约 3500 万，按照国际标准失能老人与护理人员的 3:1 标准，我国应有约 1200 万照护人员。但各类养老机构从业人员不足 50 万，距离实际需求差距较大。2024 年《养老服务人才状况调查报告》显示，养老服务人员临时工占比高达 10%，说明人员

流动较为频繁；在本次调查的 271 家养老服务机构中，有 85.6%的养老服务机构缺乏养老护理员。

（4）供给与需求错配

现阶段还是以“9073”养老模式为主。此外，中国劳动适龄人口向城市迁移，而老年人口大量滞留在乡村，地理分隔使得家庭养老作用难以有效发挥，进一步加剧了社区养老和机构养老的发展紧迫性。与此同时，现有商业养老机构定价机制尚不成熟，以泰康为例，保险产品客户需要购买 200 万元才能获得入住资格，而普通客户的入会费高达 20 万元，每月还需缴纳 1 万元会费，这使得大部分老人被拒之门外。据统计，部分养老机构床位空置率超过 50%。与老龄化水平相似的发达国家相比，中国的人均收入水平较低。在养老需求金字塔结构中，更高层次需求相关的产业市场占比则相对较小，也是部分商业养老机构发展速度较慢的原因之一。

1.3 房地产市场变化：总体进入疲软态势

房地产业是我国国民经济的重要支柱之一。然而，受紧缩性信贷政策、经济下行、突发公共卫生事件等因素的影响，2021 年下半年以来，全国房地产市场总体进入疲软态势。**供给端方面，房地产开发企业短期拿地意愿降低，土地购置面积和新开工面积减少，地产业投资增速呈同步放缓趋势；需求端方面，购房者对房地产市场和经济发展预期持悲观态度，购房意愿降低。**对当前形势分析可见，房地产行业步入收缩常态期，房地产领域发展风险增大，房地产开发企业的持续经营面临巨大挑战。

1.3.1 房地产市场下行的特点

（1）全方面降温

2021 年 7 月，我国房地产市场运行状况出现了明显的拐点信号，从繁荣发展迅速转向陷入低迷，行业风险暴露。观察数据，发现房地产基本面呈现全方面链式下行，具体表现在以下 4 个方面：

房地产行业内企业个数降幅增大。2021 年房地产开发个数为 105434 个，相比 2020 年有所增加，但同比增长率减小；2022 年房地产开发企业个数为 103852 个，同比下降了 2%。这可能是由于市场其前景不明朗，进入房地产行业的市场

主体减少，或因部分房地产开发企业破产退出市场所致。



图 28 2013-2023 年全国房地产开发企业个数及其增长率

来源：国家统计局

土地成交规模自 2020 年以来首次同比大幅下降。2020 年至 2022 年期间，全国房地产开发企业购置土地面积和土地成交价款均呈明显下降趋势。其中 2022 年房地产开发企业购置土地面积为 10041.7 万平方米，同比下降 53%；2022 年房地产开发企业土地成交价款为 9163.8 万平方米，同比下降 48%。房地产开发企业拿地面积和金额的大幅下降，体现出房地产开发企业对房产销售的悲观预期。



图 29 2013-2023 年房地产开发企业购置土地面积和土地成交价款及其增长率

数据来源：国家统计局

房地产开发投资增速下降。根据国家统计局数据，2021 年全国新建商品住宅

开发投资完成额为 102034.6 亿元，同比增长 6%，相比往年增速放缓。2022-2023 年全国新建商品住宅开发投资完成额均出现明显下降；2023 年投资完成额下降至 83820.0 亿元，同比下降 9%。2021-2022 年全国新开工商品住宅面积呈现大幅下降趋势，2022 年同比下降 40%；2023 年下降速度放缓，但总体上仍呈减少走势。

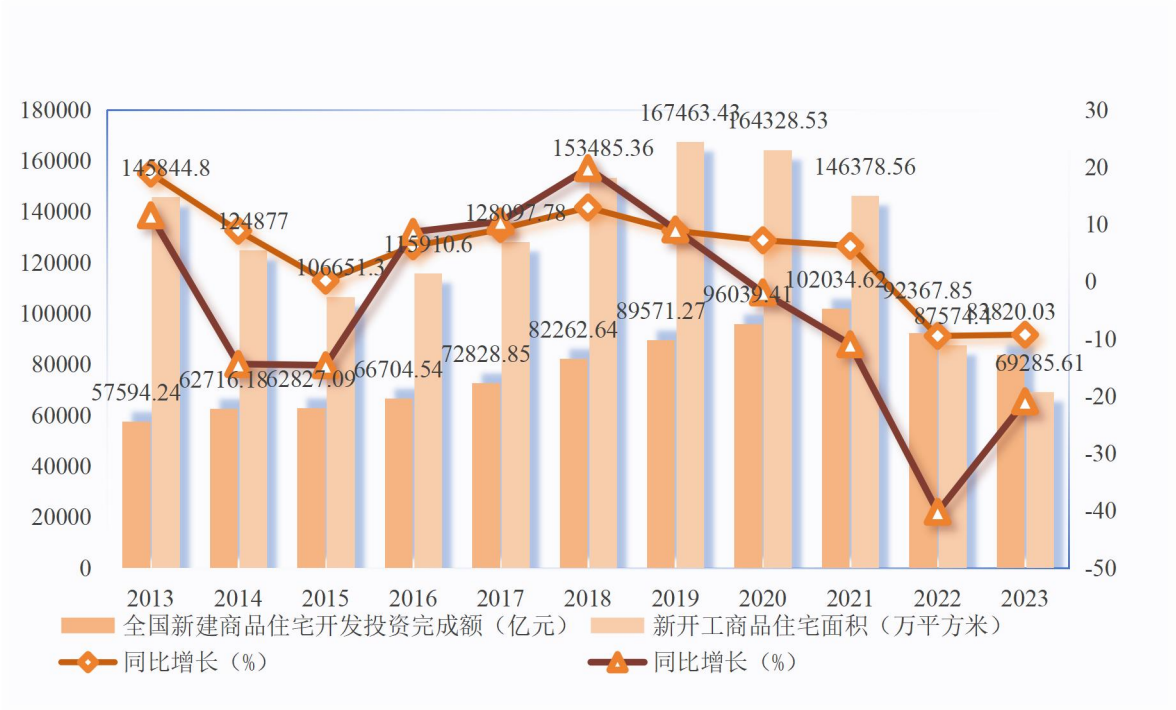


图 30 2013-2023 年全国新建商品住宅开发投资完成额和新开工商品住宅面积及其增长率
数据来源：国家统计局

新房市场的交易规模同比增长收窄。自 2014 年以来，我国商品住宅交易始终保持稳定增长趋势。但到 2022 年，全国住宅销售套数出现同比下降。据测算，2021 年全国住宅销售套数为 9597561 套，同比下降 27%。2022-2023 年全国新建商品住宅面积均呈下降趋势，2022 年同比下降 27%，2023 年同比下降 13%。2022 年全国新建商品住宅销售金额为 113669.7 亿元，同比下降 28%；2023 年继续下降至 102990 亿元，同比下降 9%。这反映出购房者购房意愿降低，对于房地产开发企业资金回流造成负面影响。

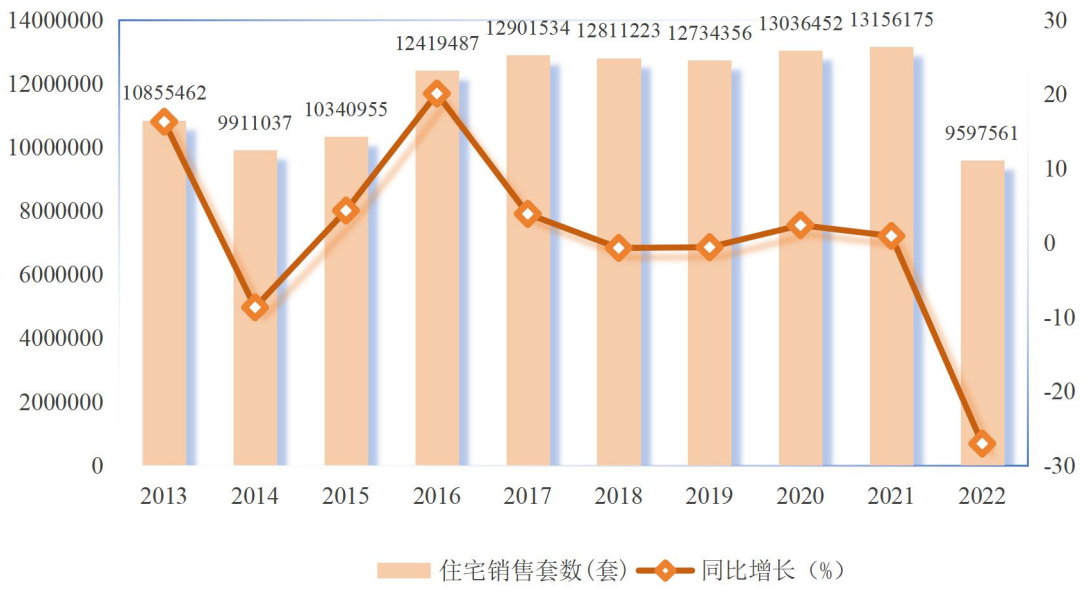


图 31 2013-2023 年全国住宅销售套数及其增长率

数据来源：国家统计局

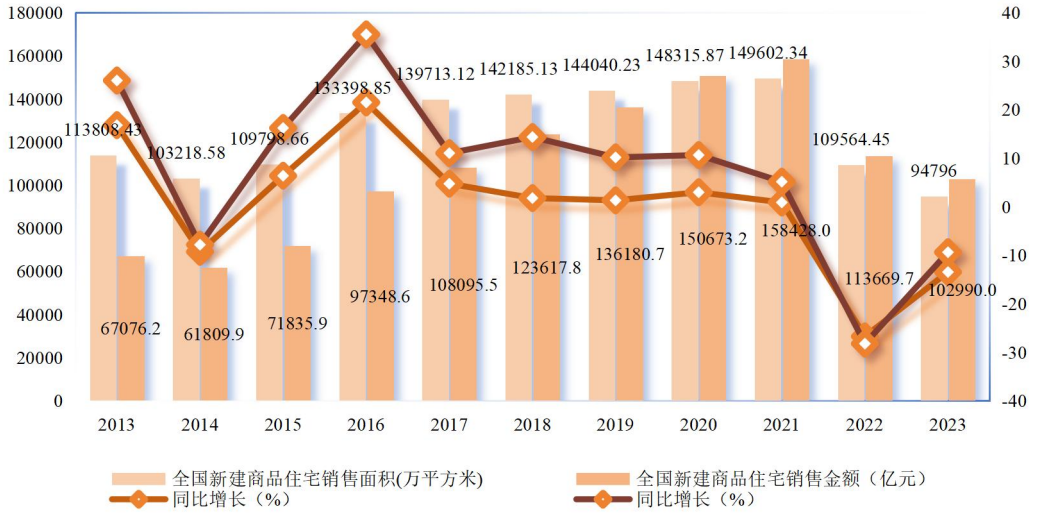


图 32 2013-2023 年全国新建商品住宅销售面积和销售金额及其增长率

数据来源：国家统计局

（2）区域分化加深

在房地产市场整体下行的背景下，市场的信用分层更加凸显，区域之间的产业分化进一步扩大，部分一级、二线城市的产业发展优于全国平均水平。据统计，2022 年上海、北京的房地产业增加值增速分别为 0.9%和-1.2%，分别高出全国平

均水平 6.0 个百分点和 3.9 个百分点；同时，北京、上海的商品住宅销售面积同比增速分别为-6.1%和-1.5%，降幅远低于全国平均水平。然而，部分省份的房地产市场发展却低于全国平均水平。如，辽宁省商品住宅销售面积下降 36.4%，相较于全国平均降幅高 12.1 个百分点。房地产业区域发展分化加强，也势必对不同地区的经济增长支撑作用产生差异化影响，进而影响区域经济增长的平衡性。

1.3.2 房地产市场下行的成因分析

（1）恶性循环效应

近年来，我国开始逐步加强对房地产供给端的调控，颁布了一系列金融紧缩政策。2020 年，国家提出“三条红线、四档管理”，根据房地产企业债务状况实施差异化的债务管理措施，严格管控房地产企业有息负债规模增速。同年，实施房地产贷款集中度管理制度，进一步加大了对房地产企业资金链的监管力度。在严格调控政策的影响下，我国房地产企业的信贷资源结构与信贷期限结构出现了显著变化，房地产行业的融资受到约束。

需求端方面，在房地产企业延期交房、房价下跌、房屋质量下降甚至烂尾等问题的背景下，购房者的购买预期下降。同时，国家针对家庭部门也出台一系列限购限贷、增加房产转让营业税和房产税等政策，抑制投资性住房需求。购房者住房购买需求下降，导致房地产企业经营现金流减少，影响房地产企业回款。

在融资和销售双重挤压下，房地产企业现金流压力增大，信用违约现象频发。据统计，2014-2019 年期间，房地产开发企业的违约债券余额占比长期低于 4%。但在 2020 年，房地产违约债券余额占全市场的比重开始提升（8%）。2021 年房地产违约债券余额显著增加，房地产企业违约情况进一步加剧。

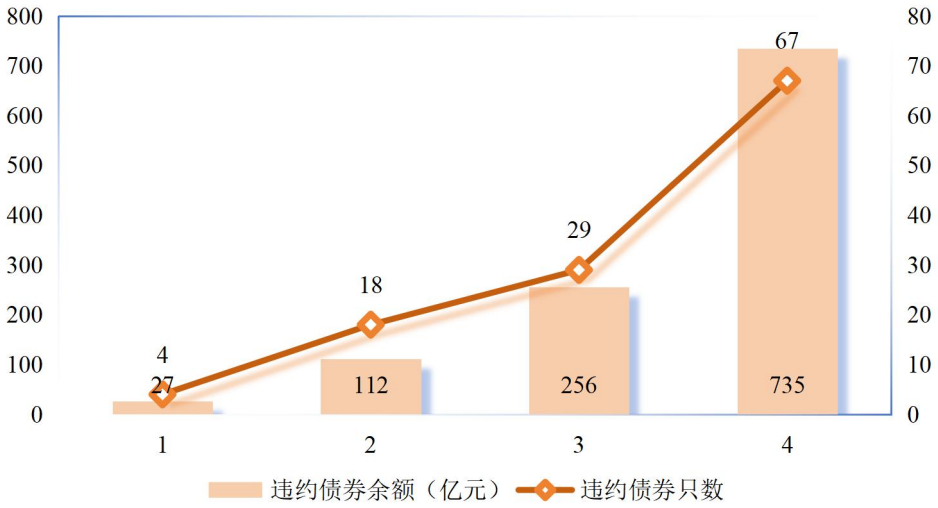


图 33 2018-2021 年全国房地产债务违约情况

数据来源：wind，贝壳研究院

受销售下滑和房地产企业出险影响，金融机构对房地产企业的房贷更加谨慎，进一步加剧房地产企业再融资困难、销售遇冷、经营风险等问题，房地产行业发展状况进一步恶化。

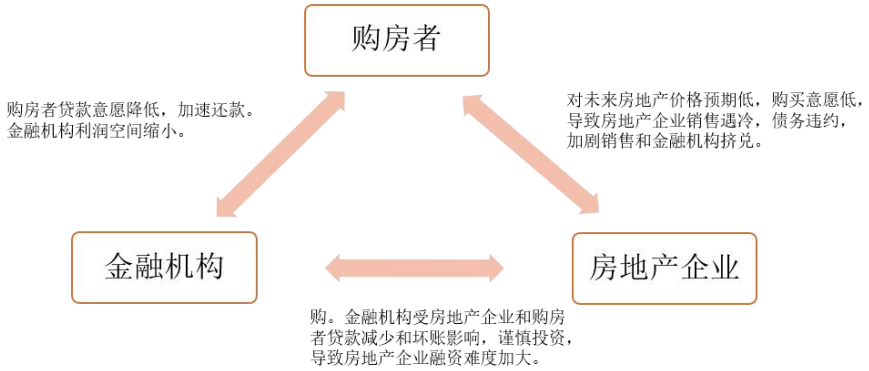


图 34 房地产发展恶性循环图

来源：团队成员整理

（2）房地产市场需求在长期下行的周期中叠加了短期下行力量

“十四五”以来，我国进入快速发展后期，近三年城镇化率年均提高 0.65 个百分点，增速有所放缓。结合上文分析，当前我国人口出生率下降和老龄化程度加深。这些因素导致房地产市场在较长一段时间内的需求中枢水平下降。

短期内，在疫情扰动和经济增速放缓的背景下，居民收入预期降低，同时 2021 年下半年以来房价上涨预期被打破，加重了居民购房的观望情绪和对商品房按时交付等风险的担忧，居民的购房需求下降，住房消费由过去多年形成的提前消费机制转变为理性消费、延迟消费。

长短期因素叠加给房地产市场运行带来了诸多不确定因素，我国房地产市场进入了深度、持续的下调时期。

1.3.3 房地产市场发展进入转型时期

（1）政策逐步放宽，发展环境有所改善

针对房地产行业的发展难题，2023 年前后我国政府开始调整房地产相关政策，改善房地产行业恶性循环状况。

2022 年 11 月，交易商协会、央行和证监会持续出台政策，支持房地产企业在银行信贷、债券和股权方面的融资。2023 年 10 月，中央金融工作会议提出“一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求”。2023 年 11 月，央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会提出了“三个不低于”政策，指导房地产行业的贷款支持。2024 年 1 月，住房城乡建设部、金融监管总局联合发布《关于建立房地产融资协调机制的通知》，全国 29 个省份建立起房地产融资协调机制。因此，房地产开发投资有所改善，房地产企业融资环境逐渐宽松。

与此同时，有关部门颁布了降低最低首付比例、降低住房公积金贷款利率、取消房贷款利率下线等一系列新的需求侧宽松政策。自 2022 年开始，三四线城市和核心一二线城市相继松动限购限售政策，提高公积金贷款额度；2023 年 7 月，发改委提出要支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作；2024 年 10 月 17 日举办的国新办新闻发布会上，住房和城乡建设部、财政部、国家金融监管总局等部门推出“四个取消、四个降低、两个增加”的政策，力促房地产市场止跌回稳。

总体而言，有关部门出台的一系列政策措施，有利于提振市场信心，房地产行业将迎来新的发展空间。

（2）市场需求变化，诱导房企转型升级

在社会经济发展和人口结构调整过程中，居民对于住房的需求也经历了深

刻的需求变化，政策调控的加强和金融环境的变化也促使房地产开发企业必须优化资产结构。这些变化要求房地产企业从传统的开发模式转向更加注重产品质量、服务创新和跨领域投资等模式。部分地产商已经开始逐步探索新的商业模式。

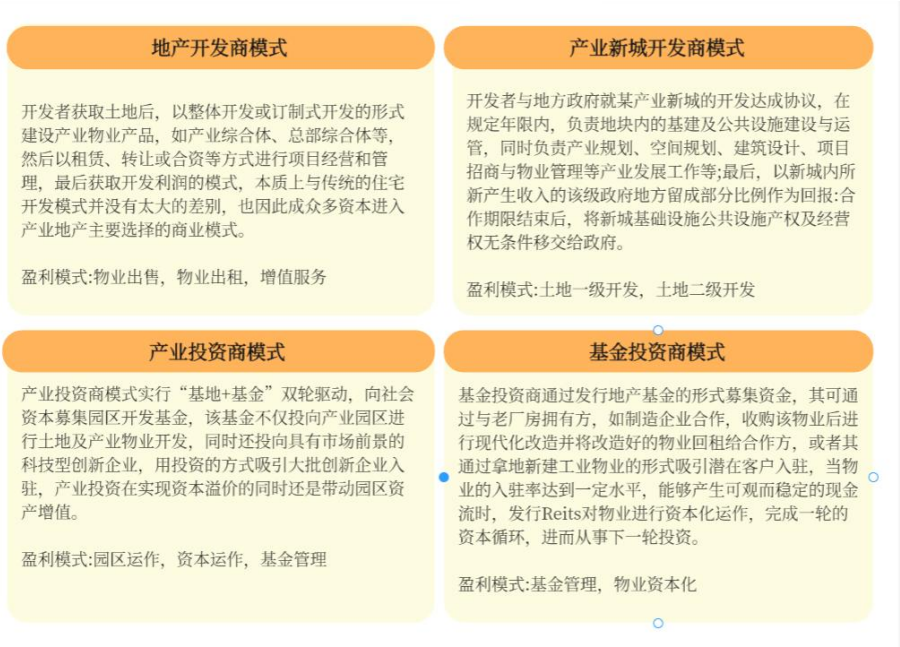


图 35 四大地产商业模式

来源：团队成员整理

上文提到，我国人口老龄化加速发展，家庭结构变化以及文化观念的转变，家庭养老模式难以满足老年人需求；市场化多层次养老需求增量演进，银发经济市场广阔，但当前社区养老和机构养老服务供给却存在明显缺口。**基于此，部分房地产企业在转型升级过程中瞄准养老地产行业，建造了一种为老年人提供多层次多功能服务的新业态，进一步挖掘存量业务机会。**

二、行业分析

养老地产是指“在人口老龄化背景下，以地产为载体、养老为核心，将住宅、商业及养老服务融合在一起，为老年人提供养老服务，以满足其需求的一种新兴业态”。本部分将对养老地产进行行业分析，以了解目前我国养老地产行业的基本情况及所面临的困境。

2.1 养老地产行业 PEST 分析

PEST 分析是一种用于评估行业外部宏观环境的工具，主要包括政治（Political）、经济（Economic）、社会（Sociocultural）和技术（Technological）四个评价维度。下面将使用 PEST 分析方法对我国养老地产的宏观环境进行分析。



图 36 养老地产行业 PEST 分析

来源：团队成员整理

2.1.1 政治环境：相关政策提供总体要求、指导与支持

国家高度重视养老产业的发展，出台了多项政策以指导并支持银发经济发展，对养老产业发展提出总体要求。2021 年，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，文件强调“要推动老龄事业和产业有效协同、高质量发展”。2024 年，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，该文件进一步指出“要推动有效市场和有为政府更好结合，促进事业产业协同，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展”。

具体到养老地产行业而言，相关文件也为其发展提供了政策指导和政策支持。一方面，国家对养老地产的发展提供了政策指导，主要包括“优化存量设施利用机制”和“科学规划新增养老用地”两个方面。第一，可利用存量资源改建养老设施。早在 2019 年，自然资源部发布的《自然资源部关于加强规划和用地保

障支持养老服务发展的指导意见》就已提出“已建成城区养老服务设施不足的，应结合城市功能优化和有机更新等统筹规划，支持盘活利用存量资源改造为养老服务设施”。2024 年，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》进一步指出“在确保安全的前提下，支持利用闲置商业、办公、工业、仓储等存量场所改建养老服务设施。”**第二，应该科学规划新增养老用地。**2021 年，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》指出要“科学编制供地计划，分阶段供应规划确定的养老服务设施用地，并落实到年度建设用地供应计划”。更进一步地，2024 年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出“新建居住区按照人均用地不少于 0.1 平方米的标准分区分级规划设置社区养老服务设施”的要求。

另一方面，国家对养老地产的发展提供了政策支持，主要包括**“土地政策支持”“规划和报批建设支持”和“财税政策支持”**。根据 2019 年发展改革委、民政部、卫生健康委联合发布的《城企联动普惠养老专项行动实施方案(试行)》，国家和政府主要提供三方面的支持：第一，土地政策支持——设置专门的养老用地类别，优先安排土地利用计划；第二，规划和报批建设支持——依法简化养老服务开办申报程序，营利性养老机构增设营业场所时，无需办理分支机构营业执照；第三，财税政策支持——营利性养老机构可享受财政补贴，并减半收取行政事业性收费（包括土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费、不动产登记费、防空地下室易地建设费）。2024 年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》也再次强调“要持续优化养老行业营商环境”，为其提供更加有力的规划、土地、财政、投资、融资、人才等政策支持。

2.1.2 经济环境：房地产市场下行但养老服务需求增加

近五年来，**我国经济增速放缓，但 2023 年国民经济有所回温向好**。根据国家统计局数据，2023 年国内生产总值比上年增长 5.2%。面临全球经济不确定性，中国经济仍保持相对稳定的增长，这为养老地产行业的发展提供了一定的经济基础。

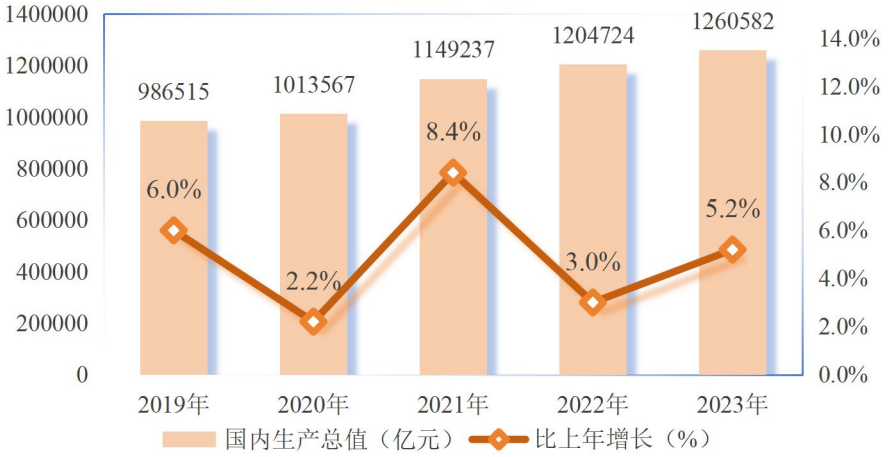


图 37 2019 年-2023 年国内生产总值及其增长速度

数据来源：国家统计局《2023 年国民经济和社会发展统计公报》

具体到房地产经济而言，如本报告第一部分所述，全国房地产市场总体进入疲软态势，房产需求和供给两端均呈现明显的下降趋势。**在房地产行业下行背景下，推动养老地产发展有利于形成新的经济增长点，提振房地产经济**。

与此同时，正如前文所述，我国目前已进入深度老龄化社会，**庞大的老龄人口基数无疑刺激了养老需求的增长，为银发经济的发展提供了广阔的市场**。伴随着人口老龄化的加速推进，养老服务需求不断增长，并呈现出多元化、多层次的特征。此外，**随着居民收入水平的提高，老年人及其家庭对高品质养老服务的需求增加**，这将推动养老地产行业的发展。国家统计局的数据显示，2023 年全年全国居民人均可支配收入 39218 元，比上年增长 6.3%。

2.1.3 社会环境：传统家庭养老面临挑战叠加养老观念发生转变

一方面，我国家庭结构的变化影响着老年群体养老方式的选择。由于历史因素（如计划生育政策）、生育观念等方面的原因，家庭规模日益呈现出小型化的特征，这将导致**家庭的养老负担加重，传统的家庭养老模式面临挑战**，社会对专业养老服务的需求增加。第七次人口普查数据显示，2020 年平均每个家庭户的人口为 2.62 人，比 2010 年第六次全国人口普查的 3.10 人减少 0.48 人。

另一方面，**伴随着社会经济的发展，老年人的养老观念将逐渐转变，对养老地产的品质和服务水平有了更高的要求**。大象保险发布的《2023 年中国商业养老服务供需洞察白皮书》显示，尽管被调查者选择居家养老，但是也有相当一部

分的群体选择机构养老等其他养老方式，并且中年群体的机构养老意向高于老年群体。这意味着养老地产的未来发展具备广阔的发展空间。

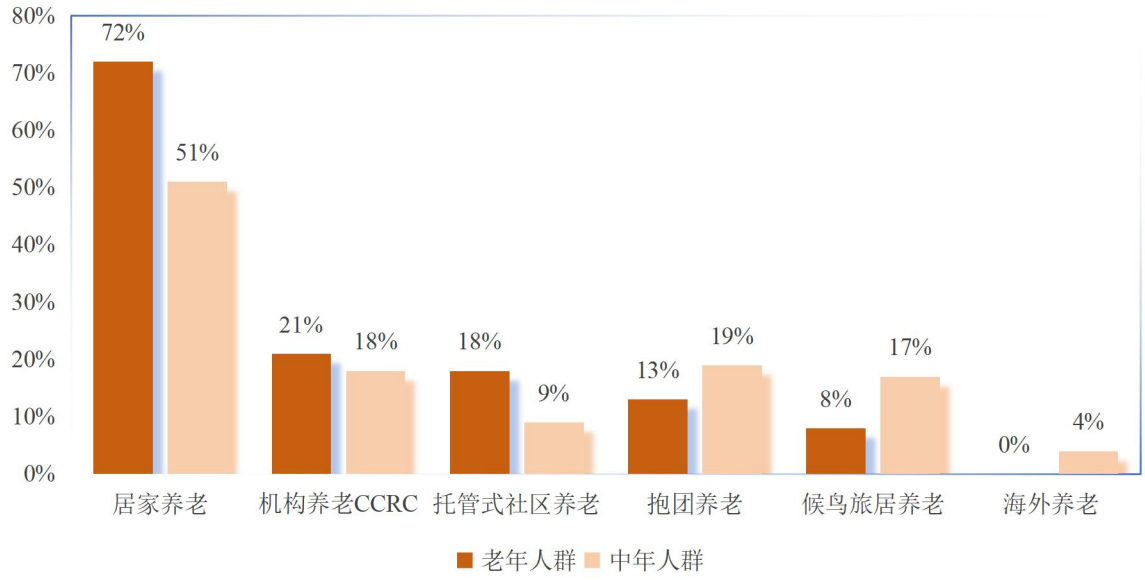


图 38 老年人群及中年人群未来想选择的养老方式

数据来源：大象保险《2023 年中国商业养老服务供需洞察白皮书》

2.1.4 技术环境：新兴技术应用与医养结合推广

伴随着新兴技术逐步应用于养老产业之中，养老服务的质量和效率不断提升，以此更好地满足老年群体多样化、个性化的养老需求。

第一，智慧养老逐渐成为养老地产行业的重要趋势。物联网、大数据、人工智能等先进技术将深度融入养老地产，实现健康管理、紧急救援、日常照护等服务的智能化与精准化。**智能穿戴设备、远程医疗服务**的普及，将极大提升老年人生活的便利性。适老化设计包括**无障碍设计、智能家居系统、紧急响应系统**等技术的应用也将提升老年人生活的幸福感和安全性。

第二，医疗技术的发展和医养结合模式的推广，使得养老地产项目能够提供更全面的健康服务。医养结合是未来养老地产发展的重要方向。通过引入专业医疗机构、建立绿色通道等方式，确保老年人在社区内即可享受便捷的医疗服务。

2.2 发展养老地产行业的必要性和可行性

结合 PEST 分析内容，我们认为在当前阶段发展养老地产行业是必要的也是可行的。

就必要性而言，当前我国国民经济增速放缓，同时房地产市场并不景气，推

动养老地产发展有利于**刺激经济发展、释放消费潜力，进而形成新的经济增长点**。此外，在人口老龄化、少子化深入发展的当下，**发展养老地产、提供商业养老服务将与公共养老服务协同推进、相互补充**，共同助推并实现"老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐"。

就可行性而言，第一，**国家及地方层面陆续出台相关政策以规范和促进养老产业发展**，并为养老地产行业提供了一定的土地政策支持、规划建设支持及财税政策支持。第二，**养老地产具备一定的市场空间**。我国庞大的老年人口基数催生了巨大的养老服务需求，同时由于社会经济的发展，老年群体的养老服务需求呈现出了多层次、多样化、个性化的特征，加之规模日益缩小的家庭结构也为机构养老提供了发展机遇。这些都为养老地产的发展提供了可观的市场潜力。

2.3 行业产业链分析

2.3.1 行业全景

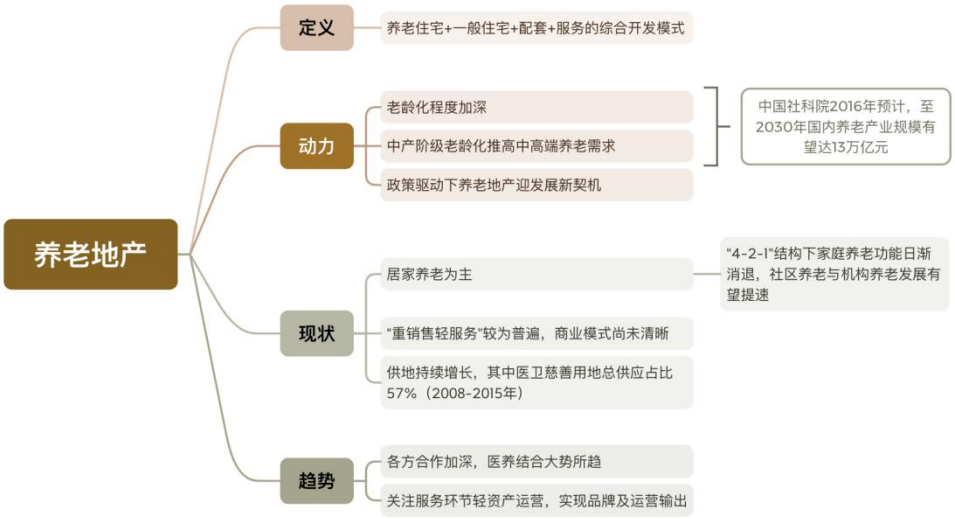


图 39 养老房地产行业全景

来源：公开数据

养老地产将养老产业与房地产行业结合，服务目标为老年人群体，提供具有完备设施的住宅和符合老年人身心需求的综合性服务，包括居住养老、医疗护理、健康管理和文娱活动等内容。

表 2 养老地产的分类

地产类型	养老模式	地理位置	特点
养老社区	养老社区养老	城市郊区	建有养老住宅、养老公寓、护理中心、医疗中心老年大学、文娱活动中心等各种养老配套设施，还兼顾其他人群需求，比如幼儿园休闲商业、度假酒店等。
老年公寓	机构养老	城市中心	医养结合，配备专业康复和护理机构，提供各式文娱服务。
养老驿站	居家社区养老	社区中心	提供短期全托、日托、膳食供应、生活照料康复护理、紧急救援、文娱活动、交通接送等服务同时为老人提供居家养老服务，如上门医疗护理家政、餐饮、陪同出行等。

来源：智研咨询

2.3.2 产业链分析

（1）养老地产在整个养老行业中的位置

养老行业作为一个综合性强、涉及面广的领域，其内部包含着多个相互关联、相互影响的环节和组成部分。其中，**养老房地产作为中游产业链的关键一环，扮演着至关重要的角色**。

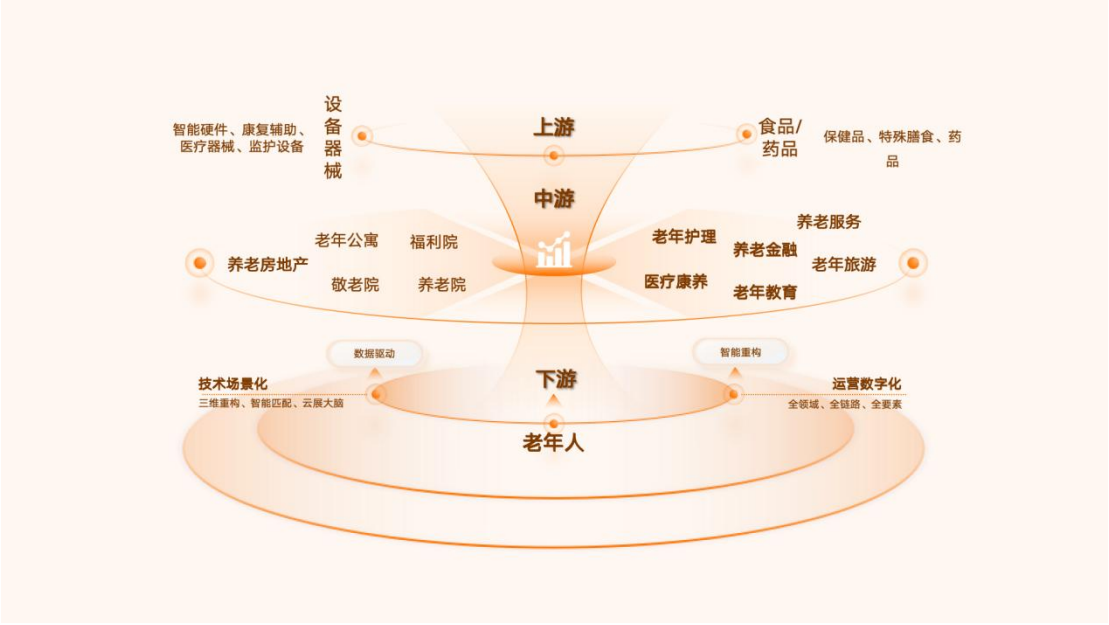


图 40 养老行业产业链

来源：团队成员整理

从产业链的角度来看，养老行业可以大致划分为上游、中游和下游三个部分。**上游部分主要包括食品药品、智能硬件、辅具、保健品、特殊辅食以及医疗器**

械等生产供应环节，这些环节为养老行业提供了必要的物质基础。中游部分则涵盖了老年服务、老年护理、养老金融、老年教育以及医疗康复等多个服务领域，这些领域直接面向老年人群体，提供全方位、多层次的养老服务。而下游部分则更多地关注老年人的生活质量和社会参与，包括老年人服务（可能涉及社区服务、居家服务等）以及公众参与等方面。

在养老行业的中游产业链中，养老房地产是核心环节。它不仅为老年人提供了安全、舒适、便捷的居住环境，还通过整合上下游资源，为老年人提供了包括生活照料、医疗护理、健康管理、文化娱乐等在内的全方位服务。

同时，养老房地产还与其他中游服务领域如老年服务、老年护理、养老金融等紧密相关。这些服务领域相互协作、相互促进，共同构成了养老行业的完整产业链。

在养老房地产开发领域，除地方政府作为关键推动力量外，还汇聚了多元化的市场主体，包括专业的地产开发公司、传统养老机构以及保险机构等。此外，跨行业的联合开发模式也日益兴起，不同领域的企业通过资源整合与优势互补，共同推动养老房地产市场的创新与发展。

表 3 中国养老地产主要开发商分类

主要参与者	代表企业
地产开发商	万科地产、绿地集团、华润置地
保险机构	泰康人寿、中国平安、中国人寿
医疗机构	同仁堂、北控医疗、欧葆庭
跨界异业	首钢就按、中国普天、金陵饭店

资料来源：观研天下

总之，养老房地产在养老行业中处于中游产业链的关键位置，它不仅是老年人居住和生活的重要载体，更是连接上下游资源、提供全方位服务的重要平台。

（2）内部产业链分工

1.按照市场角色分析

养老产业链是一个多维度、多主体交织的复杂系统，核心构成可划分为养老

住宅与服务供给方、目标消费群体以及养老资金筹措机制三大板块。在这一体系中，政府、地产开发企业、专业养老服务机构、保险公司、其他投资实体以及老年群体共同构成了产业链的参与者。

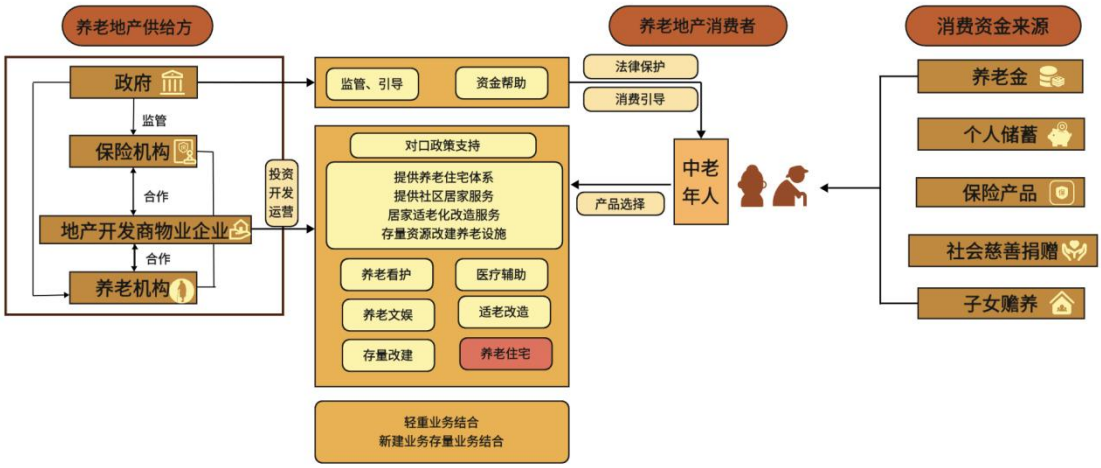


图 41 按照市场角色划分养老地产产业链

来源：小组成员整理

2.按照上中下游来分析

养老地产行业的产业链构成，可系统地划分为上游、中游与下游三大环节。

上游部分涵盖金融服务、建筑施工、规划设计、土地供应及政策监管。金融服务作为资金链条的关键节点，通过银行贷款与投资机构的介入，为养老地产项目注入资本血液；建筑施工环节则依托施工单位与建材供应商的紧密合作，确保项目实体建设的顺利进行；规划设计环节则依据老年人的居住需求，打造适宜老年人生活的空间环境；土地供应方面，政府作为土地资源的分配者，通过出让土地为养老地产项目提供物质基础；政策监管层面，政府部门与行业协会则通过制定并实施相关政策与标准，对养老地产行业实施有效的监管与引导。

中游部分聚焦于房地产开发、营销推广及法律服务三大领域。房地产开发环节由专业的养老房地产商与项目公司主导，负责项目的整体开发与建设；营销推广环节则通过营销代理与广告宣传等策略，提升项目的市场认知度与销售业绩；法律服务环节则依托律师事务所的专业力量，为项目提供法律咨询与产权登记等法律服务，确保项目的合法性与规范性。

下游部分涵盖了养老服务消费者、投资者及服务提供者三大主体。养老服务消费者作为养老服务的直接受益者，包括老年人、家庭及支付方等；投资者则包括个人、机构、政府及非政府组织等，他们通过投资养老地产项目，推动行业的持续发展；服务提供者则提供包括物业管理、餐饮服务、文化娱乐、健康管理等在内的多元化服务，为老年人创造更加优质的生活环境。整个产业链通过上下游的紧密衔接与协作，共同构建了养老地产行业的完整生态系统，为行业的健康发展提供了坚实的基础。

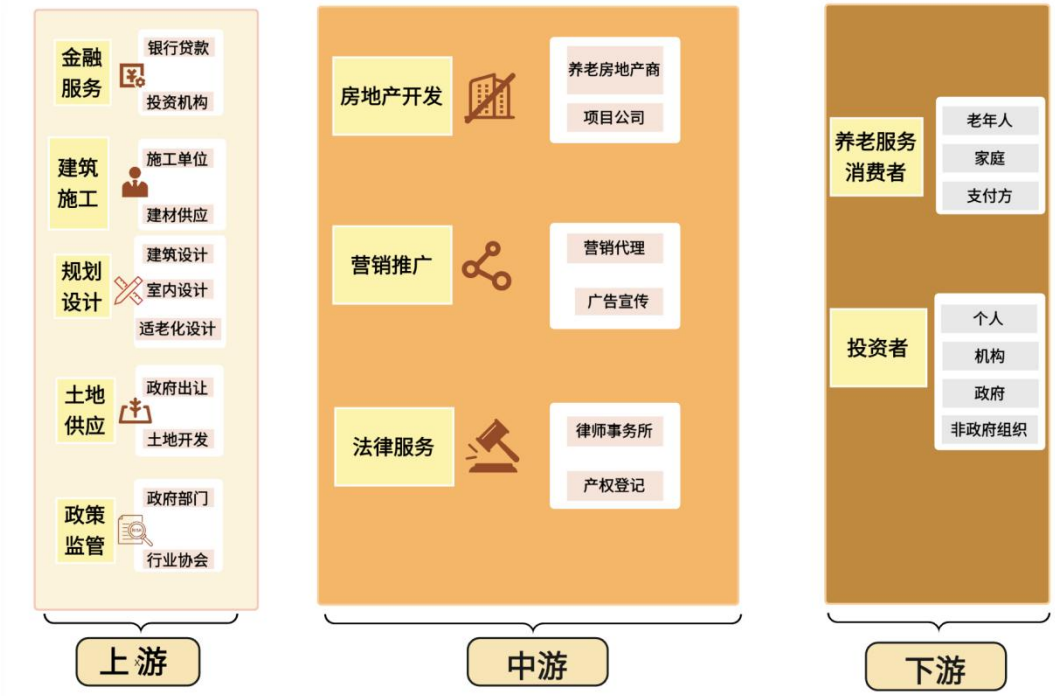


图 42 养老地产行业产业链

来源：小组成员整理

近年来，养老地产行业吸引了房地产企业、养老服务机构、保险机构以及其他投资机构的广泛关注与积极参与，共同构建了养老地产行业的完整产业链。从前瞻产业研究院提供的数据来看，中国养老产业的代表性企业在床位数和城市布局上呈现出显著的差异。这种差异不仅反映了企业在养老地产领域的不同规模和实力，也暗示了行业内部竞争的激烈程度。

表 4 中国养老产业代表性且关键指标对比（单位：个）

企业	业务类型	床位数	区域布局
泰康之家（北京）投资有限公司	养老、护理、康复实验体建设运营和创新的服务，以康养为中心，对接保险产品	2470	北京、上海、广州、成都、苏州、武汉、杭州
燕达国际健康城投资管理有限公司	养老基地和康养运营业务	10000	北京
远洋养老运营管理有限公司	长者社区、老年公寓和护理站	4874	北京、天津、上海、广州、成都、重庆、武汉、大连
上海爱以德医养投资集团有限公司	养老院、护理院和护理站	6000	上海
北京光大汇晨养老服务有限公司	机构养老服务、社区养老服务和旅居养老服务	1300	北京、山东、江苏、陕西、河南、海南、银川、山西、浙江
亲和源集团有限公司	居家养老、社区养老和机构养老为一体	/	上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚
上海凯建华展养老院有限公司	高端养老院	/	上海、宁波、苏州
北京诚和敬投资有限责任公司	养老机构及养老驿站	308	北京
乐成老年事业投资有限公司	养老社区、养老机构和社区医疗	/	北京、海南、浙江
欧葆庭（上海）投资有限公司	颐养中心	/	南京、长沙

来源：前瞻产业研究院

2.4 国外发展情况

根据前文描述，全球在 21 世纪初便正式进入老龄化社会，养老服务需求激增，各国纷纷探索建设和完善养老服务体系。基于不同的市场环境和老年人口特征，各国的养老地产行业发展模式呈现差异化特征，为我国养老地产的发展提供了借鉴。

2.4.1 美国——成熟的资本化多元养老体系

20 世纪 60 年代，美国基于社区模式的养老地产开始起步，经过 50 多年的发展，已形成一个结构完善、门类齐全、高度资本化的养老住宅体系。美国主流的养老机构均属于民办形式，养老院 80%以上的收入来源于私人支付。

（1）美国养老地产主要模式

美国养老地产的发展方向是差异化养老社区，目前形成太阳城模式、持续照料社区模式（简称 CCRC 模式）、房地产信托投资基金（REITs）参与投资模式。

太阳城模式。太阳城养老地产主要针对 55-70 岁的康健老人，提供住宅、康乐会所和户外运动等设施，主要依赖周边区域的医疗机构提供医疗、护理服务。

该模式下，地产开发商通过销售养老概念住宅回收前期投资和产生利润。由于选址一般在郊区，太阳城养老地产项目的房价相对较为便宜，且住宅类型丰富多样，其入住率高达 90%以上。

CCRC 模式。在美国，持续护理退休社区（CCRC）是由运营商主导提供精细化管理服务的复合型养老社区，服务内容包括餐饮、医疗保健、生活和医疗护理，会针对自理型老人、介助型老人、介护型老人提供差异化的服务内容。目前，CCRC 模式只提供地产租赁权和服务享受权，运营商主要通过收取房租租赁费、入门费、特殊服务费等来获利。其中，入门费价格为 20 万-100 万美元不等，年费或月费视老年人健康状况而定，价格区间为每月 3000-6000 美元，特殊服务费由个体所需的特定额外护理服务来定。

REITs 模式。美国的养老或医疗地产类 REITs 是养老地产的主流投资商，其投资方式主要有净出租和委托经营两种模式。前者是 REITs 公司将养老业务出租给运营商，通过收取固定租金费用获取收益，运营商承担经营风险，其通过全部经营收入提出租金费用、运营成本后获得剩余收益；后者是 REITs 公司将养老物业托管给运营商，运营商收取管理费，REITs 公司承担经营风险和核算剩余经营收益。大多数 REITs 公司会采用净出租方式。REITs 模式下金融机构直接参与养老地产的开发和运营投资，从而使得开发商获得更好的退出渠道。



图 43　美国养老地产行业多样化发展

来源：团队成员整理

（2）美国养老地产的发展特征

美国养老产业最大的特点是投资、开发和运营相分离。投资商主要负责以担保等形式为建筑商提供融资支持、购买和持有物业、确定物业经营模式，通过收取租金或营业收入来盈利。建筑商根据投资商的要求开发建设养老社区和出售物业，利润来源为建设成本间的差价和物业销售收入。运营商担任维护和使用物业、提供养老服务职能，通过营业收入或经营管理费用获利。

美国养老运营商实施规模化发展策略。美国养老运营市场集中度较高，前十

大运营商占有行业 60%左右的项目和资产。截至 2018 年 6 月，前十大运营商拥有项目 2502 个、房间数 31.2 万间；其中龙头运营商 Brookdale 拥有 994 个项目、9.6 万间房间。规模化发展成为美国养老运营商降低经营成本、提高盈利能力的关键。

2.4.2 日本——政府支持下的标准化服务

日本养老地产行业发展水平较高，老年居所类型多达十几种，硬件情况、提供的护理服务、入住难易程度及入住费等存在较大差异，可以满足多元化老年群体的需要。

（1）日本养老地产的主要模式

从运营模式上看，日本养老地产可以划分为“住宅”和“机构设施”两大类。住宅类地产主要是由个人或单位向老人出租空闲房屋并提供养老服务的经营模式，其入住的对象主要为 60 岁以上具备生活自理能力的健康老人。住宅类地产可以进一步细分为高龄者住宅、年长者住宅、银发住宅等。机构设施类地产是由开发商建造各种适合老人居住的房屋和设施，并提供护理、娱乐等服务的一种模式。机构设施类地产包括护理型医疗设施、老人疗养设施、特别护理住家、收费老人住家等模式。与住宅类养老地产不同，机构设施类养老地产中的“收费老人住家”必须为老人配备各项护理和照料服务。

日本养老地产主流的两类经营模式是住宅类养老地产中的“高龄者住宅”模式和机构设施类养老地产中的“收费老人住家”模式。“高龄者住宅”模式下，日本政府会为符合规定的民间团体、医疗法人或社会福利法人提供建筑建设补助和税收减免，同时各级政府会搭建面向老人和房东房屋租赁信息平台，促进双方的交易，房东主要通过收取租金、管理费、护理服务费等获取收入。由于有政府资助，服务型高龄者住宅只能用于出租，且其收费收费标准不高，因此该类型住宅的平均入住率较高。“收费老人住家”模式下，开发商的成本支出主要包括购买土地、设施建设、设备采购和服务人员工资等，其中服务人员工资占运营成本的一半左右，这使得该模式下聘用工资较低的非全日制护工或派遣工的现象较为普遍。近年来，面积在 20 平米左右并配置单独的小厨房和盥洗室等公共区域的“收费老人住家”单元日益流行，开发商可以通过这种方式收取更多的入住金，再加上管理费、餐饮费、护理费等收入，从而收回建设成本，增加经营利润。

（2）日本养老地产的发展特征

政府法律法规支持体系完善。1961 年，日本开始实施《国民年金法》，建立起包括国民年金、雇员年金、企业年金的强制性、多层次的养老金收入体系。2000 年，日本颁布《介护保险法》，建立介护保险制度，指导老年居所建设和运营，实现居家养老和机构养老互补。2001 年推出《高龄者居住安定确保法》；2007 年颁布《关于促进租赁住宅供给的法律》，由政府主导加大老年住宅的市场供应。随后，又相继制定《老人保健法》《护理保险法》《住宅品质确保法》等法律体系，保障养老产业持续运转。

以地缘性客户为市场基础。与中国养老院大多位于郊区不同，日本的养老地产项目大多布局在成熟的居住区，依托地理位置优势开展便捷的日间照护、上门服务等介护服务，延长养老地产产业链，增加开发商利润收入。

实行小规模连锁化经营。日本养老项目规模普遍较小，房间数大多集中在 50-150 间左右。小体量、紧凑户型、精简的人员配置的经营方式有利于降低养老地产开发商的先期建造和运营成本投入，缩短销售周期，进而实现资金回流和降低融资贷款风险。在此基础上，日本养老地产项目大多通过连锁化经营，实现规模经济。

2.4.3 国外养老地产发展经验总结

（1）制定完善的养老保障制度体系

美国和日本都建立多层次的养老保障制度。目前美国已建成由美联邦政府强制社会养老金计划、雇主养老金计划和个人储蓄养老金构成的“三支柱”养老保险体系；日本实施介护保险制度和多层次年金计划，同时各级政府还颁布了包括众多养老地产相关支持性政策，支持养老地产的经营和发展。

（2）建立良好的资本市场运作机制

养老地产开发的明显特征是资金需求量、运营成本高、资金回流周期长，这对开发商的融资和经营能力提出了较高要求。美国凭借发达的金融市场发达、健全的信用体系、完善的信息披露机制等优势，将各级政府养老保险预算管理信息及时公开，逐步完善以证券为主导的直接融资体系，实现了养老地产的投资、开发、经营等全方面的支持性产业链和资本运作机制。日本的养老地产融资强调政

府的作用，一方面政府制定相关政策激励民间资金参与融资，发展养老服务；另一方面，政府自身也积极投入资金参与养老地产的开发运营。建立良好的资本市场运作机制有利于降低开发商资金风险，促进养老地产行业的持续发展。

（3）实施多元化、规模化发展战略

受年龄段、社会经济地位、健康状况等因素的影响，老年群体的养老服务需求呈现多样化、多层次的特征。相应地，养老地产应当开发不同类型的养老社区，提供差异化服务。如美国的太阳城模式面向健康老人，CCRC 模式也根据老年人的失能程度提供差异化的服务内容；日本的住宅类地产和机构设施类地产均可细分为不同的类型。

2.5 国内发展情况

2.5.1 我国养老地产的模式

根据老年人居住时间的长短，可以将我国老年地产分为两种模式：“常住型”和“候鸟式”。

表 5 我国养老地产模式

	类型	代表案例	主要内容	特征
常住养老	房屋出售	万科幸福汇、东方太阳城	房屋出售为核心，同时提供完备的养老服务	养老服务+产权出售
	CCRC	保利安平—和熹会	以大型医疗机构为核心，建立老年社区，涉及场地出租、房屋出租、养生活动等	仅包含房屋出租和养老服务提供，不涉及产权出售
	物业参与	适老化改造：上海地产集团的适老化改造服务平台 存量改造：首开寸草 养老服务：椿龄康养	以社区养老为依托，构建适老化社区，物业企业在原有社区基础上提供日托、上门、餐饮、娱乐等方面的养老服务	依托存量住宅构建养老社区
	以房养老	南京汤山留园、北京太阳城	老人把房子抵押给保险公司，保险公司通过一系列精算定期发放给老人定额养老金。房主去世之后，房产出售来还清贷款	保险服务+中介机构
“候鸟式”	度假养老	台湾长庚养生文化村	旅游地产	自有资金为主
	异地养老中心	大连互动式异地养老中心	根据季节在不同养老地切换	

来源：团队成员整理

（1）常住养老地产

1.房屋出售模式

《中国老龄事业发展“十四五”规划》提出，要大力促进社区养老的发展，促进社区养老服务设施发展完善。房屋出售式的养老地产开发模式要求建设符合老龄人口需求的社区环境，需要涵盖公共配套措施、医疗机构、娱乐设施等多方面的建设。构建“一刻钟”居家养老服务圈，这意味着老年人在家中或社区内能够获

得各种养老服务。

表 6 房屋出售模式养老地产

	东方太阳城	万科幸福汇
特点	以养老为题材的房地产开发项目	
规模	80万平	16.4万平
运营模式	房屋出售	房屋出售，公建出租
基础配套	东方嘉宾国际酒店、康体中心、5万平太阳会所、菜地认领	1.5万平老年公寓和活动中心
医疗特色	东方太阳城医院	无

来源：团队成员整理

2.CCRC 模式

CCRC 社区能够老年人在健康状况和自理能力发生变化时，仍能在熟悉的环境中继续生活。CCRC 的主要人群分为三种：自理性老人、介助型老人和介护型老人。CCRC 社区能够为不同年龄段和照护需求的老人提供相应的设施和服务，使得老年人在不需要搬家的情况下，就能在 CCRC 社区就能完成 1/3 的生活幸福旅程。

3.物业参与模式

随着房地产市场逐渐饱和，从增量新建到存量提质的转变也是新时代养老地产需要主攻的方向之一。通过物业参与存量业务，养老地产从过去重资本投入模式转而开辟轻运营的业务方向，吸引更多市场多主体参与。

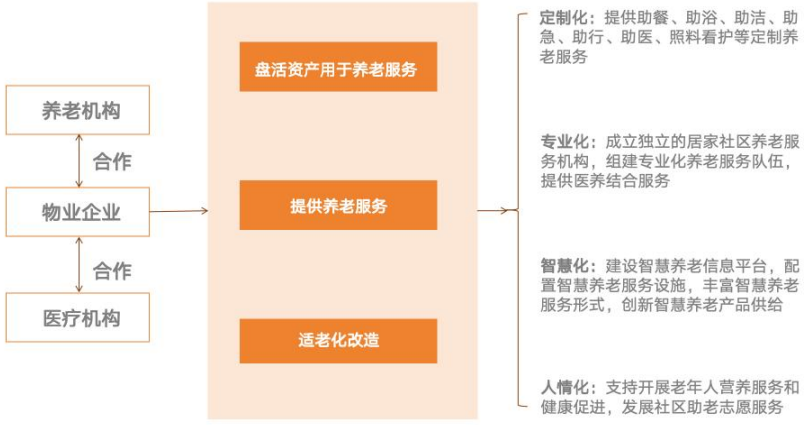


图 44 物业企业开展养老业务模式

来源：团队成员整理

（2）候鸟式养老地产

“候鸟式”养老是指老年人到异地养老的一种方式，包含旅游养老、度假养老、回原籍养老等形式。

1.异地养老服务中心

异地养老服务中心模式主要是指以季节为周期，在不同养老公寓之间置换养老服务中心。这一模式满足了旅游养老、度假养老和回原籍养老的多重养老需求。但以上模式中养老公寓从本质看仅处于廉价旅店和养老护理中间的地位。养老机构本身不乐意看到所照顾的老人出现频繁更换，而老人自身对于异地环境的适应性、养老医疗等是否可以异地使用的条件也使得以上养老模式发展受到制约。

2.度假养老基地

以养老服务为核心，推广度假文化是这种养老模式的核心。这种养老模式最大的优势在于，可以结合全家人的互动活动，定期度假，来满足老年人的养老需求。一方面通过旅游地产主打休闲度假，另一方面在休闲之余引入医疗、保健、定期康复、养生学习等内容。



图 45 度假式养老地产模式

来源：团队成员整理

2.5.2 我国养老地产的投资模式

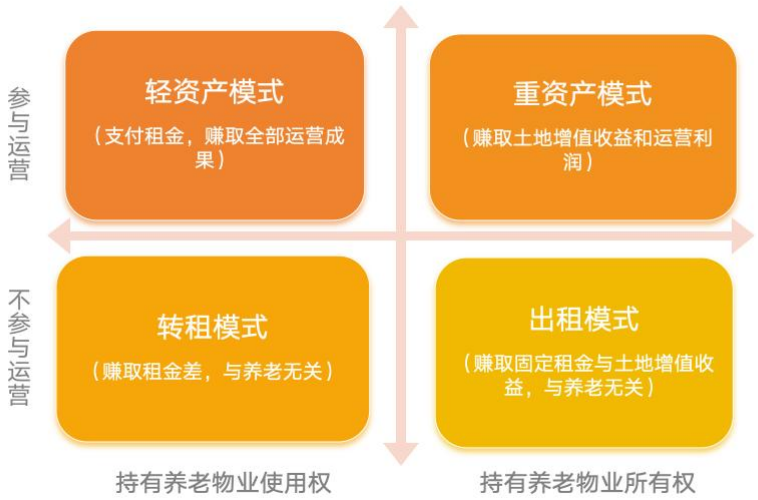


图 46 我国养老地产模式

来源：团队成员整理

（1）重资产模式

重资产模式指的是投资主体不仅取得土地所有权，还负责养老地产建设和后期运营的模式，往往拥有物业所有权。重资产模式的优点是对养老地产控制权较大，容易建成统一标准，适合全国推广布局。缺点在于重资产模式前期投入大，投资收益周期较长。

（2）轻资产模式

轻资产模式是指投资主体通过租赁的方式来获取物业的使用权。优点在于开发周期和投资回报周期较短，能够较好适应各地的市场特色。缺点在于对养老地产建设的过程控制性较弱，面临着租约到期等不确定因素。

2.5.3 我国养老地产的盈利模式

（1）养老地产的主要盈利点

1.赚土地的钱

市场上大部分定位养老的项目，均是以养老和适老为卖点，在产品的市场细分上倾向于老人居住。此部分的盈利点最容易实现，也是开发商最希望赚到的钱。

2.赚配套的钱

以养老地产为名，通过养老配套的完善，提升项目竞争力。当社区成熟后，养老文化的形成，社交聚集的圈层效益，均有利于提升物业价值。

3.赚服务的钱

以服务和设施作为养老地产的核心，通过细分市场，研究老年人的活动规划，进行有针对性的设计，形成成熟的服务体系、管理体系。

4.赚产品的钱

以老年人的需求为核心，开发相应的产品和提供相应的服务，让老年人买到真正需要的产品，引导老年人健康生活。

（2）养老地产的中期盈利模式

养老地产的中期盈利模式最大的特点是**一次性收益为主，持续性收益为辅**。

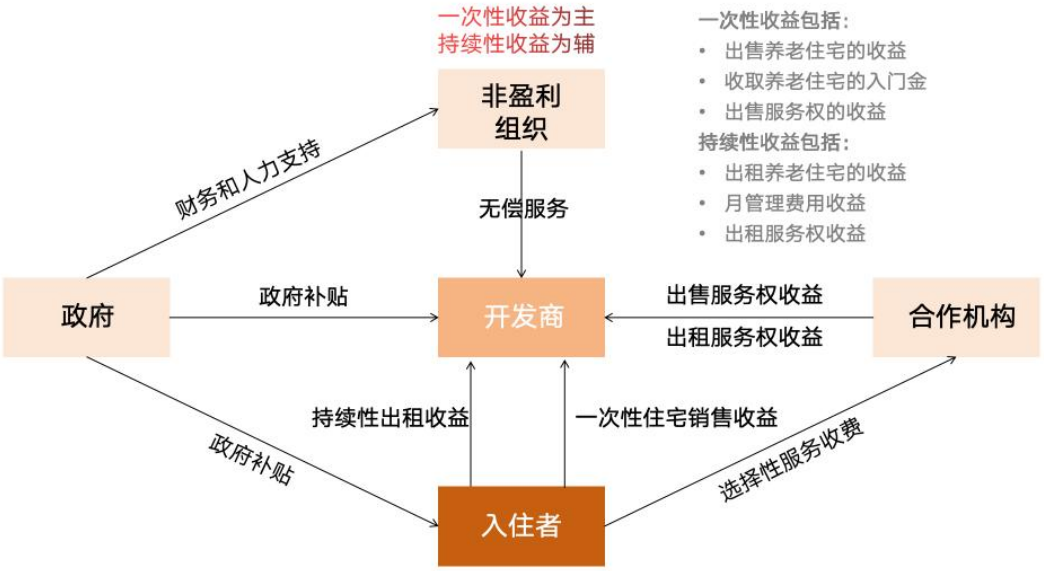


图 47 养老地产中期盈利模式

来源：团队成员整理

（3）养老地产的发展成熟期盈利模式

在养老地产的发展成熟期，发展出一种投资、开发、运营相分离的模式。养老地产开发商的收入主要有三部分：**运营权出让收入、服务项目分成、出售收入或出租收益**。

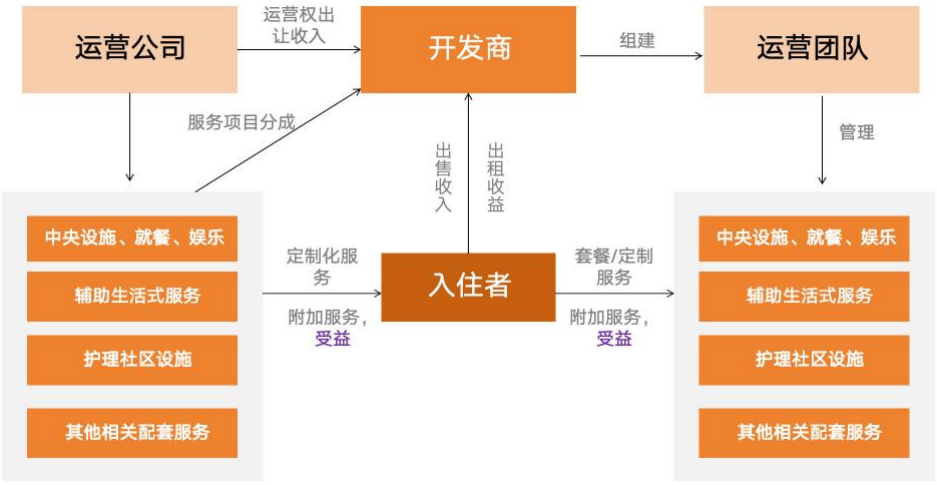


图 48 养老地产成熟期盈利模式

来源：团队成员整理

2.5.4 我国养老地产的投资主体

近年来各路资本加快养老产业行业布局，房企、保险、医疗机构等强强联合，目前已有上百家房地产企业和保险机构布局养老地产产业。中国房地产协会《2021 中国养老健康产业发展报告》指出，养老产业仅主板上市企业就有 82 家：其中 32 家主营房地产，14 家主营医疗健康和医药制造，5 家主营金融保险。

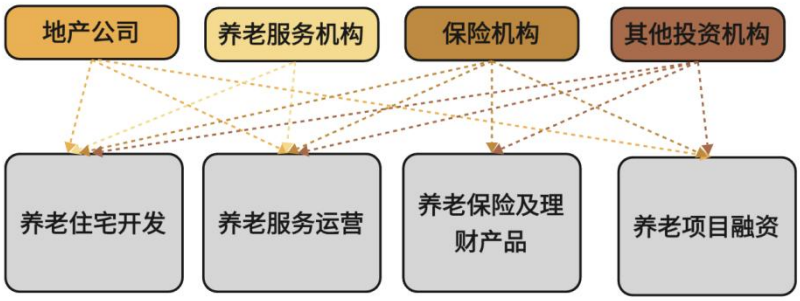


图 49 我国各路资本布局养老地产

来源：团队成员整理

(1) 保险系企业

保险系养老机构是指由保险机构投资、建设和运营的养老机构。以保险为依托的养老机构保险公司通常拥有长期、稳定的资金，适合投资于养老产业这种长

期回报的项目。如泰康保险集团，目前在养老社区项目上的投资总额已经达到 299 亿元人民币。保险系养老机构的优势主要体现在两个方面：一是方便协同推进保费收入增长的养老服务和保险产品；二是保险公司在国际合作老年人健康管理方面，可以利用业务特点获得优势。

表 7 我国大型险企投资养老地产概括

保险企业	养老品牌	主要项目
泰康人寿	泰康之家	北京燕园、上海申园、广州粤园、成都蜀园、杭州大清谷等
中国人寿	国寿家园	北京大兴的国寿加元韵境、苏州阳澄湖半岛的国寿嘉园雅境、海南三亚的嘉园逸境、天津空港经济区的国寿嘉园乐境
中国平安	养生养老综合服务	桐乡项目
中国太平	梧桐人家	上海浦东周浦项目
合众人寿	合众优年	武汉项目
恒大人寿	恒大养生谷	海南三亚项目
新华人寿	新华家园	北京莲花池养老公寓
幸福人寿	九久夕阳红养老	合肥、巢湖、宿州等九家养老公寓

来源：团队成员整理

（2）地产系企业

地产系养老机构是指由房地产企业投资、开发和运营的养老机构。该类养老机构通过“投资—拿地—开发—运营”，参与了完整的养老产业链。地产系养老机构的发展优势也体现在两方面：一是养老机构的设计和设施布置可以充分考虑老年人口的需求，包括无障碍通道、宽敞的居住空间、紧急呼叫系统等。二是地产系养老机构的运营模式可能包括销售模式、租售结合、床位出租、会员制模式以及金融组合模式。

表 8 部分房地产开发企业养老品牌

企业	养老品牌/项目
万科	随园
越秀	海颐苑
保利	和悦会、和熹会老年公寓
绿城	绿城椿龄荟、乌镇雅园、颐养公寓
远洋	椿萱茂
首开	寸草养老
龙湖地产	椿山万树
中海地产	中海锦年
九巨龙	孝养城
金地集团	颐养公寓
南京朗诗	常青藤
黄山圣天地	医康养智慧社区
特变房产	幸福小镇
保定卓正	颐和雅园康养小镇
复星集团	星堡

来源：团队成员整理

（3）产业配套跨界企业

投资养老地产的产业配套跨界企业通常涉及多个行业，包括但不限于医疗、教育与娱乐等。这些企业通过与养老地产的结合，提供全面的服务和产品，以满足老年人的多样化需求。

表 9 跨界布局养老地产业务

企业名称	原有业务	养老地产业务
金陵饭店	酒店住宿	养老旅居地产
大族激光	激光	养老旅游
海南椰岛	酒、饮料和精制茶制造业	养老旅居
上海三毛	纺织业	养老地产物业管理
易华录	信息服务	智慧养老
首钢	钢铁	养老产业园
同仁堂	医药生物	医养结合
中国普天	信息服务	智慧养老

来源 ：团队成员整理

2.6 行业目前的痛点

中国的养老地产与发达国家相比，还处在一个探索期。目前来看，还存在以下五方面的发展难点。

2.6.1 地区分布不均

从全国分布来看，养老地产项目区域分布不均衡，呈现四大养老地产聚集区。我国养老地产主要在京津冀、长三角、珠三角和川渝四大地区分布，其他地区分布较少。

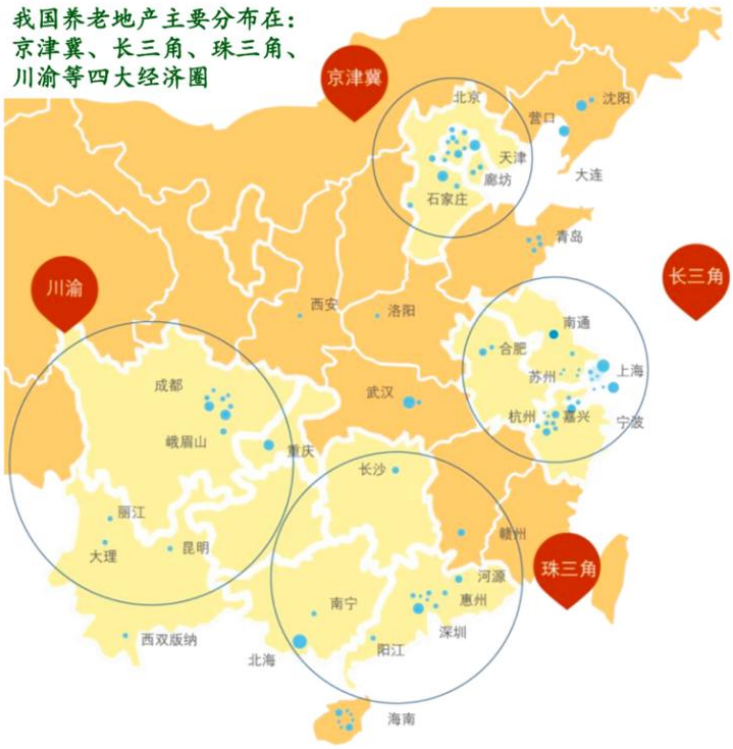


图 50 我国养老地产分布

资料来源：平安证券

2.6.2 空置率较高

在已经形成的产业聚集区中，养老地产空置率较高。在四川、重庆地区的养老地产空置率有 47.5%；东部地区较川渝地区稍好，但空置率也约为 40%；珠三角地区表现最好，空置率大概为 36.9%。但对于一般的养老院而言，至少需要达到 75%以上的入住率才能实现盈利。因此，大多数养老地产项目因为入住率的问题难以扭亏为盈。

2.6.3 投资市场不完善

在国外成熟养老地产模式中，ReitS、ABS 等是重要融资手段。与国外相比，中国企业难以获得大额的、融资成本较低的资金。国家扶持的诸如保险资、政策贷款、专项债券等均无法成为主流的资金供应渠道。此外，受限于传统房地产行业的拍卖拿地方式，养老地产开发公司拿地成本也居高不下，进一步加大了资金压力。

2.6.4 供给市场两极分化

中大型公司开发的养老地产以高端市场为主，服务质量高，收费标准较高，收费区间在 8000-30000 元每月，较高的门槛将许多老人拒之门外，因此导致养老园区床位空置率较高，部分养老地产处于亏损当中；小型公司开发的养老社区提供的养老服务质量较差，基础环境设施也保持在维生水平。两种供给类型都无法满足大部分老人的养老需求。

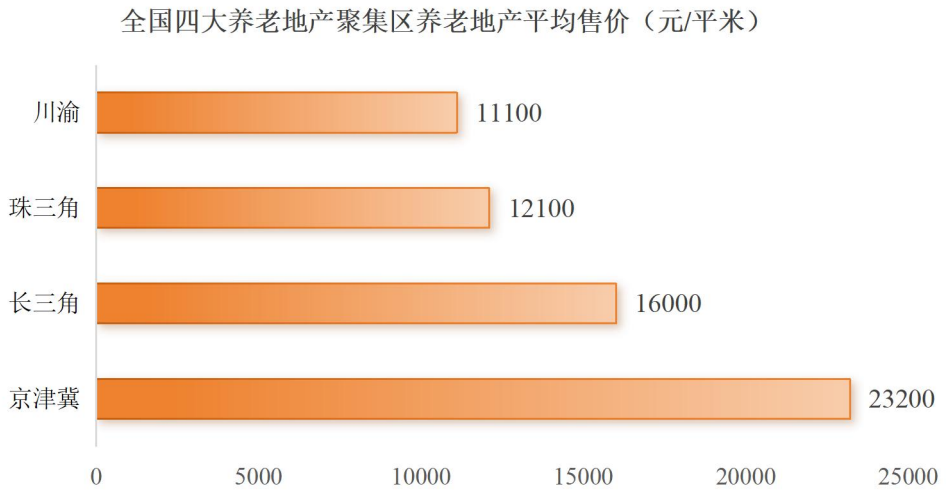


图 51 全国四大养老地产聚集区养老地产平均售价

来源：前瞻产业研究院

表 10 补贴养老机构收费对比

养老机构	收费水平	服务水平
公办养老机构	2000-4000元/月	环境好，设施完备，护理周到，配备医疗设施，一床难求。
低端民营养老	1600-3500元/月	基本维生水平，缺乏娱乐设施。空间狭小阴暗，多人间为主。
中端民营养老	3500-7500元/月	基础设施完善，生活娱乐分区。空间较大，具有四人间/三人间/双人间/单间。
高端民营养老	8000-30000元/月	环境好，设施完备，养老社区，适老性建筑。

资料来源：前瞻产业研究院

2.6.5 盈利模式和运营模式不成熟

当前养老地产开发最大的问题是投资收益周期较长，盈利模式不健全，导致资本下场较为谨慎。在已有的投资主体当中（除去保险系企业），还未形成规模，缺乏标杆企业和可复制的成功经验。

三、案例分析

上一部分对我国养老地产行业进行了整体的分析，并总结了行业目前存在的痛点。在此基础上，我们将引入 CCRC 模式，进行具体介绍并开展案例分析，希望能为我国养老地产行业的发展提供借鉴。

3.1 CCRC 模式介绍

CCRC 是一种复合式的老年社区，通过为老年人提供自理、介护、介助一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和自理能力变化时，依然可以在熟悉的环境中继续居住，并获得与身体状况相对应的照料服务。**CCRC 的核心在于提供从独立生活到全面护理的无缝过渡，确保老年人在生活的各个阶段都能获得适当的照护和医疗服务。这种模式既不同于机构养老和居家养老，而是融合了居家、机构和社区的优势特征，实现了居住人群、产品形态、服务功能的复合。**

3.1.1 运作模式



图 52 CCRC 运作模式图

来源：团队成员整理

(1) 服务对象

CCRC 模式的服务对象主要有三类：

1.自理型老人。55-65 岁之间的老人，居住者独立居住，生活可以自理。社区为这部分老人提供方便快捷的餐饮、清洁洗衣、医疗保健、紧急救援等社区服务。同时，社区还将针对老年人的精神生活需求，组织老年大学、兴趣社团等形式多样的活动。

2.介助型老人。当老人生活出现不能自理的部分，他们将变成介助型老人。介助老人得到的服务内容除社区服务之外，还包括日常生活照护，如饮食、穿衣、洗浴、洗漱及医疗护理等，社区还会为介助型老人提供与他们的身体状况相适应的各类活动。

3.介护型老人。该类型的老人往往缺乏生活自理能力，由专业护理员提供 24 小时的全程监护服务。基于特别的照护需求，介护型老人单独居住在特定的单元中。

（2）服务内容

CCRC 模式提供不同功能的分区。依据老年人的自理程度，将老年人居住区域进行业态划分，当老年人照顾需求发生变化时，可搬至相应居住区，而不必搬出社区。**社区内主要包括独立生活区、协助生活区、专业护理区、特殊护理区。**

表 11 CCRC 模式功能分区介绍

分区	功能
独立生活区	为健康群体提供居住服务，入住者日常生活几乎不需辅助
协助生活区	为需要部分照料的老年人提供居住服务，居住个体分开，但公共设施在同一区域
护理区	为生活基本无法自理的老年人提供 24 小时有专业护士照料的监护服务
特殊护理区	为特定老年群体提供特殊护理，如认知症照顾区，提供照护支持、非药物干预、认知康复等服务

来源：团队成员整理

CCRC 模式提供丰富多样的养老服务。主要包括**居住服务、生活服务、医疗服务、护理服务、其他服务**等。居住服务主要包括提供多样化的房型设计和配备适老化设备，以提供舒适、安全、适老化的住宅单元，满足不同老人的住宿需求。

生活服务包括提供餐饮、清洁、洗衣等日常生活辅助。医疗服务包括提供预防、保健、治疗等医疗保健。护理服务包括提供日常照护、专业护理等护理照顾。同时，部分 CCRC 社区也会提供其他服务以满足老年人社交、文娱等方面的个性化需求。

（3）经营模式

1. 运营模式。就国内目前情况而言，委托运营、独立运营以及合作运营是主要的运营模式。目前国内 CCRC 养老社区项目的运营方式以开发商独立运营为主，少数项目属于合作运营。一方面是因为 CCRC 养老社区项目规模较大，对运营要求高。另一方面，因文化传统以及社会保障制度的差异，进入国内的国外养老服务运营商需要本土化。

2. 盈利模式。CCRC 养老社区项目的居住产品可以分为养老公寓和养护院两类，其中养老公寓对应的是以“套”为单位养老公寓，收费模式灵活多样，诸如产权销售、会员制、租赁（长租和短租）、保险模式等。因为产权销售受土地性质的限制较大，目前采用这种方式的项目减少。养护院对应的是以“床”或“房”为单位的养老床位，收费方式以收取床位费、服务费和餐费为主。

表 12 CCRC 模式的盈利模式

收费模式	收费方式	收费内容
产权销售	产权销售	产权销售+年服务费
租赁	长租	一次性床位费+月服务费+餐费
	短租	月床位费+月服务费+餐费
会员制	会员制	会员费+月服务费
保险模式	保险模式	保险+入住押金+月费

来源：团队成员整理

3.1.2 CCRC 模式在我国的适用性与优势

CCRC 模式主要有提供一站式服务、熟悉环境持续生活、推动医养结合、提供社区支持、集中管理和服务五方面的特点，在我国具有一定的适用性和优势。

第一，一站式服务满足多样化养老需求。CCRC 模式能够集中提供居住、医疗、文娱等养老服务，同时面向自理型老人、介助型老人、介护型老人提供不同

类型的养老服务，有利于满足我国老年群体多样化、多层次的养老服务需求。

第二，熟悉的环境满足老年人心理需求。在 CCRC 社区中，即使老年人的健康状况发生变化，也无需迁移到其他社区。在我国独特的文化背景下，"安土重迁"的观念长期存在。熟悉的环境能够让老年人产生对"家"的归属感和依赖，满足其心理需求。

第三，医养结合契合未来发展趋势。CCRC 模式强调医养结合，社区紧邻医院资源，社区内提供预防、保健、治疗等一系列的医疗健康服务。医疗需求是老年群体最主要养老服务需求之一，医养结合的模式有效地满足了老年群体需求，也与我国“医康养融合”战略相契合。

第四，社区支持促进老年人社会参与。CCRC 模式强调社区的支持网络，并通过丰富的活动和设施促进老年人的社会参与。充足的社区支持有利于降低老年群体的焦虑感和不适感，改善其心理健康和生活质量。

第五，集中管理和服务以形成规模优势。CCRC 模式通过建设复合式的社区以提供居住、生活、护理、医疗等多类需求，这种规划化经营方式将人力、物力、管理、场所等各种资源集中，有利于降低成本，从而形成规模优势并带来集聚效应。

3.1.3 CCRC 模式在我国可能面临的挑战

如前文所述，CCRC 模式与我国国情具有一定的适配性，但同时其在**资金投入、文化接受度及人才培养方面面临着一些挑战**。

首先，CCRC 模式初期投入大且回报缓慢。建设和运营 CCRC 需要大量的初始资金，且回报周期较长，这将增加供应商的资金压力。一方面，由于初期购置土地、建设老年社区、购置相关设备、聘请并培养专门人才需要投入大量资金。另一方面，由于 CCRC 模式收费方式以会员制（会员费+月服务费/年服务费）为主，资金回笼是长期过程。

其次，传统观念对集中养老的接受度不高。根据前文分析，现阶段我国老年群体还是以居家养老为主。CCRC 模式融合了机构养老和社区养老的特点，由于传统观念对集中养老模式的接受度较低，因此需要逐步引导和改变以增强老年人和家庭对 CCRC 模式的认知和接受度。

最后，CCRC 对相关人才要求较高。CCRC 之所以在美国得到长足发展，一

个非常重要的原因是多学科医疗团队的组建，包括专业医师、护理人员、社会工作者、理疗师等。而目前我国护理人才的缺口仍旧庞大，因此需要培养一批懂医疗、懂养老、懂管理的复合型人才来应对老年人多样化的需求。

3.2 案例分析：泰康之家

3.2.1 公司简介

在中国养老产业的快速发展背景下，国内已有 15 家主要保险公司投资并运营超过 70 家养老社区，涉及总投资约 1400 亿元。这些企业中，国寿侧重于重资产投资模式，以近郊 CCRC 和城市核心区的收购项目为主；大家保险则专注于城市中心的 CCRC 项目，并探索居家养老服务；太平人寿倾向于通过轻资产合作模式，与养老机构项目结合，以促进保险产品的销售；太保在长三角地区以重资产模式布局近郊型 CCRC 项目；平安保险通过打造“颐年城”和“逸享城”两条产品线，结合集团内部的医疗健康资源，提供全方位的居家养老服务。

在这一领域中，泰康保险集团的表现尤为突出，成为行业内的佼佼者。泰康自 2007 年起便开始涉足养老业务，2012 年借鉴国际经验，投资建设了首个 CCRC 项目——北京泰康之家·燕园。经过十余年的发展，泰康在养老社区项目上已占据领先地位，截至 2023 年底，在 34 个城市完成了 39 个养老社区项目的落地，其中 20 个项目已投入运营。

泰康保险集团成立于 1996 年，总部位于北京，是一家业务范围涵盖保险、资产管理和医养三大核心领域的大型保险金融服务集团。集团旗下包括泰康人寿、泰康养老、泰康在线等多家子公司，业务覆盖人身保险、互联网财险、资产管理等多个领域。

泰康 Taikang

图 53 泰康品牌标志

来源：泰康公司官网

泰康健投作为泰康保险集团的全资子公司，专注于医养健康产业的投资开发、资产管理和运营服务，以“医养康宁”服务体系为核心，构建了全国性的生态化

医养服务网络。泰康之家作为泰康健投旗下的重要品牌，致力于养老康复实体的建设运营和创新服务，采用“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”的商业模式，坚持市场化、专业化、规范化、国际化的发展理念，已成为大型高品质连锁养老机构的代表。泰康之家借鉴美国 CCRC 持续照护模式，结合中国老年人的特征，打造了高标准的医养社区。



图 54 泰康之家全国布局情况

来源：公司官网

3.2.2 商业模式

（1）泰康保险集团商业模式

泰康保险集团商业模式以“长寿时代中国样本”为战略定位，通过整合保险、资产管理和运营服务，形成了以“健康、长寿、富足”为核心的三大闭环商业模式，旨在通过“泰康之家”、“幸福有约”和“健康财富规划师”三大品牌，将保险服务与实体养老服务相结合，为客户提供全方位的健康管理和养老解决方案。

在这一商业模式中，“泰康之家”扮演着至关重要的角色。它不仅是泰康保险集团养老服务网络的重要组成部分，也是实现“长寿闭环”的关键环节。通过人寿保险和康养体系的结合，泰康之家为客户提供了安享晚年的养老社区，这与客户的寿险和年金产品紧密相连。同时，健康闭环通过健康保险和医疗体系的结合，为客户提供了从诊疗到健康管理的一系列服务。富足闭环则通过保险资金和投资体系，帮助客户实现财富的保值增值，以满足其医疗和养老的需求。



图 55 泰康之家在泰康集团商业模式中的地位

来源：公司官网

泰康保险集团的“保险+资产+运营”模式，通过保险产品实现金融属性，通过土地和不动产投资获得资产属性，并通过专业的运营服务实现经营属性。通过这种模式，泰康保险集团成功地将虚拟的保险产品与实体的养老服务相结合，使客户能够通过泰康人寿、泰康养老、泰康在线等平台实现支付，并享受到全方位健康保障。

（2）泰康之家的商业模式



图 56 泰康之家商业模式的波特价值链框架

来源：团队成员整理

泰康之家作为泰康保险集团旗下的养老服务品牌，其商业模式融合了医养结合、持续照护以及候鸟连锁服务，形成了立体的保险养老服务体系。该模式以“活

力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”为核心，通过自建团队、自创品牌和自主运营的方式，实现了养老服务的标准化和品牌化。

依托泰康保险集团的强大品牌和资源，泰康之家在内部运营上采用自建团队和独立运营的方式，实现对养老社区的高标准管理和服务；在生产和服务运营方面，提供结合医疗和照护的全方位服务，并通过智慧医养技术提升服务效率；营销与销售上，创新性地将保险产品与养老服务结合，利用庞大的销售网络和品牌效应进行推广；在服务配送上，实现全国布局，满足不同地区老人的养老需求；客户服务上，提供个性化照护方案和丰富的社区活动。支持活动包括高效的采购管理、技术创新、专业的人力资源培养和完善的企业基础设施建设。这一模式不仅确保了泰康之家能够提供高品质的养老服务，也实现了企业的持续增长和市场竞争力的提升。

1.产品模式

泰康之家的养老社区标配包括一个住区和一家医院。住区提供多样化的养老服务单元，如独立生活、协助生活和记忆障碍单元等，满足不同老年人的居住需求。休闲娱乐板块则包括会所和社区商业等，以丰富老年人的精神文化生活。医院则为自建的二级康复医院，内设综合医疗服务中心、康复中心、护理中心以及急诊急救和慢病管理体系，确保老年人能够获得及时的医疗服务。

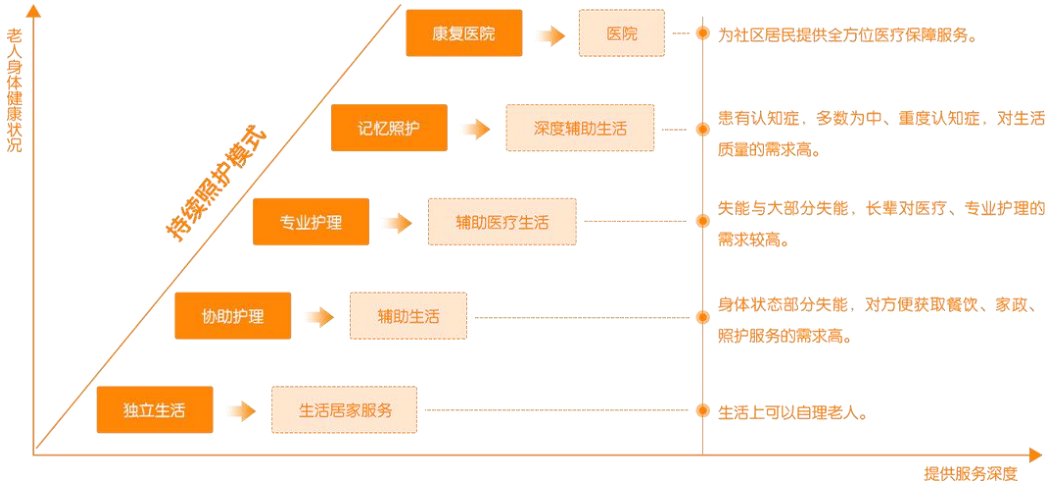


图 57 以自建医院为依托的 CCRC 持续照料退休社区

来源：公司官网

泰康之家的产品线主要分为“园”和“府”两个系列，这两个系列在区位选择和规模上有所区别，以满足不同老年人群的特定需求。“园”系列项目通常位

于城市近郊或新城，距离中心城区大约 30 至 60 分钟车程。这些区域自然环境优越，拥有公园和景区等资源，植被覆盖率高，空气质量良好。例如，泰康之家豫园项目就提供了超过 3600 个养老单元，体现了“园”系列项目在规模上的优势。此外，“园”系列项目还自建康复医院等医疗配套设施，并在周边设有满足急救需求的医疗机构，以确保居民的健康和安全。“府”系列项目则选址于城市核心区，周边配套设施齐全，便于老年人保持原有的生活方式，同时也方便子女探视。这些项目规模相对较小，例如泰康之家和平府项目仅提供 102 个养老单元。通过多元化的产品线，泰康之家不仅提升了自身的市场竞争力，也为养老产业的发展提供了新的思路和实践案例。

表 13 泰康之家各项目情况

区域	项目名称	运营时间	区位	占地（万 m²）	建面（万 m²）	养老单元
华北	泰康之家·燕园（北京）	2015.06	近郊	13.8	30.5	3000
	泰康之家·和平府（北京）	暂未开业	城心	--	0.8	102
	泰康之家·津园（天津）	暂未开业	近郊	7.1	14.3	1550
	泰康之家·蒙园（呼和浩特）	暂未开业	新城	3.2	5.8	800
	泰康之家·冀园（石家庄）	暂未开业	新城	4.8	7.7	890
华中	泰康之家·楚园（武汉）	2020.07	新城	17.5	18.7	900
	泰康之家·湘园（长沙）	2022.03	新城	13.2	19.7	2150
	泰康之家·豫园（郑州）	2023.11	新城	13.8	24.0	3600
华东	泰康之家·申园（上海）	2016.07	近郊	9.0	22.4	2100
	泰康之家·锦绣府（上海）	2021.05	城心	1.3	--	180
	泰康之家·静安府（上海）	暂未开业	城心	4.2	--	380
	泰康之家·吴园（苏州）	2019.11	近郊	23.2	18.2	1600
	泰康之家·大清谷（杭州）	2020.01	近郊	4.4	4.6	400
	泰康之家·浙园（杭州）	暂未开业	近郊	--	12.5	1300
	泰康之家·甬园（宁波）	暂未开业	新城	3.0	11.5	1300
	泰康之家·赣园（南昌）	2021.12	新城	9.3	18.1	1200
	泰康之家·鹭园（厦门）	2022.03	新城	4.8	10.6	1100
	泰康之家·徽园（合肥）	2023.07	新城	8.0	16.0	2200
	泰康之家·苏园（南京）	2023.09	近郊	6.4	6.9	1100
	泰康之家·琴园（青岛）	2023.11	近郊	5.5	7.0	850
	泰康之家·福园（福州）	暂未开业	近郊	7.6	7.3	1350

区域	项目名称	运营时间	区位	占地（万㎡）	建面（万㎡）	养老单元
华东	泰康之家·瓯园（温州）	暂未开业	近郊	7.5	13.3	1300
	泰康之家·儒园（济南）	暂未开业	近郊	11.9	21.3	2700
西南	泰康之家·锡园（无锡）	暂未开业	近郊	10.3	10.8	1210
	泰康之家·鲤园（泉州）	暂未开业	近郊	3.2	7.9	1000
	泰康之家·通园（南通）	暂未开业	近郊	6.0	11.6	1500
	泰康之家·蜀园（成都）	2018.03	新城	7.7	18.4	2050
	泰康之家·锦官府（成都）	暂未开业	城心	4.8	--	900
	泰康之家·渝园（重庆）	2023.07	新城	5.4	10.8	1350
	泰康之家·滇园（昆明）	暂未开业	新城	4.3	9.6	1400
	泰康之家·黔园（贵阳）	暂未开业	近郊	4.0	7.0	1000
	泰康之家·粤园（广州）	2017.01	近郊	11.6	14.0	1530
	泰康之家·桂园（南宁）	2022.09	近郊	15.2	23.5	1950
华南	泰康之家·鹏园（深圳）	2023.08	新城	5.4	10.8	1300
	泰康之家·三亚海［湾度假村(三亚)	2021.02	城心	--	800㎡康养体验中心	343 间客房
	泰康之家·禅园（佛山）	暂未开业	近郊	5.2	--	680
东北	泰康之家·沈园（沈阳）	2022.01	近郊	9.5	16.2	850
	泰康之家·吉园（长春）	暂未开业	近郊	6.9	10.4	1300
	泰康之家·哈尔滨养老社区	暂未开业	近郊	6.0	9.0	1100
西北	泰康之家·秦园（西安）	暂未开业	新城	4.8	9.7	1130

来源：泰康之家官网

2.服务模式

泰康之家以养老社区运营为主体，**以“医疗服务为核心，医教研险资”五位一体的服务理念为基础，旨在为老年人打造一个全方位的退休生活解决方案。**

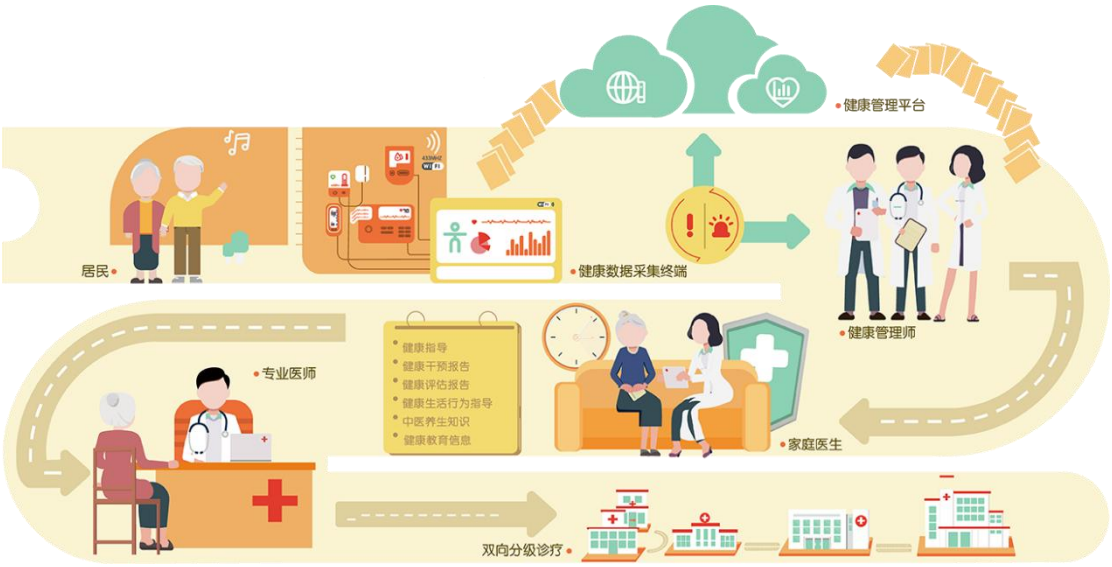


图 58 泰康之家康养融合模式

来源：公司官网

泰康之家的服务模式特别强调医养结合，实现老年人“活得好、老的慢、病的轻、平安终老”的养护目标。为此，泰康之家建立了以健康管理师为核心的“1+N”服务模式，为每位老年人配备一名健康管理师和多个专业照护团队成员，包括护理、康复、医疗、药师、社工、文娱、营养、后勤保障、感控等多个领域的专家，形成全人、全程、全方位的照护体系。

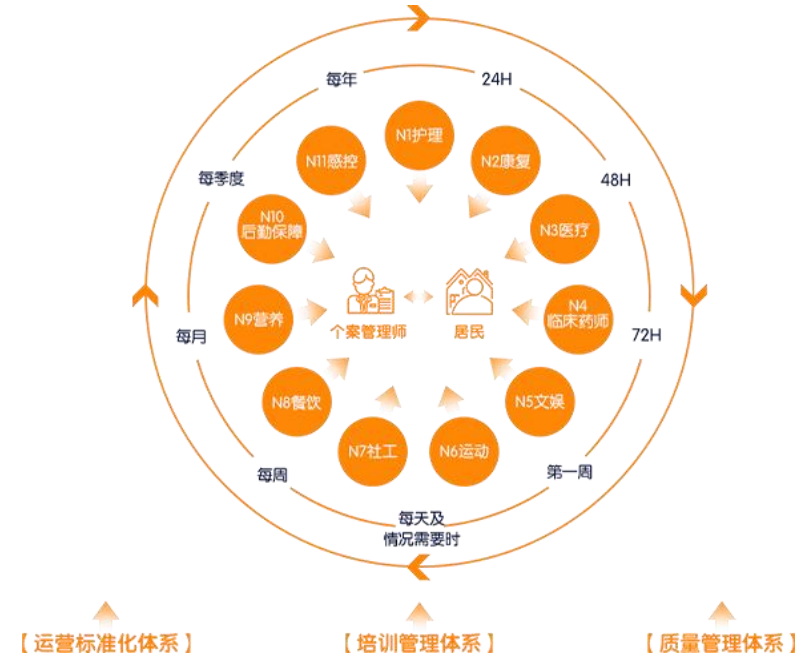


图 59 1+N 服务团队服务模式

来源：公司官网

泰康之家的服务特色体现在其三大服务体系上，分别是泰康国际标准康复体系（TKR）、泰康国际标准长期照护体系（TK-LTC）和泰康国际标准活力养老体系（TK-VC），共同构成了泰康之家的养老服务核心，旨在为老年人提供全面、专业的照护服务。



图 60 泰康之家三大服务体系

来源：公司官网

泰康之家的失智分级照护计划遵循国际失智分期护理的概念，将失智症的发展进程细分为四个阶段，每个阶段用不同颜色的蝴蝶来代表，以便于识别和制定相应的护理方案。护理方案将非常注重老人的舒适和尊严，提供 24 小时的照护，包括疼痛管理和症状控制，以及情感和精神上的支持。具体如下图所示：



图 61 泰康之家分级护理

来源：团队成员整理

泰康之家的服务模式还包括智慧养老实验室的创建，该实验室研发大健康数

字平台，围绕老年人的七大核心需求，覆盖智慧安防、智慧健康、智慧餐饮、智慧照护、智慧文娱、智慧运营等八大领域、30 多个服务场景，为社区居民提供实时、快捷、高效、低成本的智能化的健康养老服务。



图 62 泰康之家智慧护理

来源：公司官网

3.收费模式

泰康之家的收费体系体现了其养老服务的分层化和个性化，旨在为不同需求的老年人提供定制化的服务方案。该收费体系由三个核心组成部分构成：保险产品相关费用、入门费用以及月度服务费用。

首先，针对通过购买泰康人寿幸福有约系列年金保险产品的客户，泰康之家提供了保险与养老服务相结合的模式。客户通过购买保险产品，可以提前锁定入住权，保费总额约 200 万元左右，缴费方式灵活，包括 20 年分期支付、5 年分期支付或一次性趸交。

其次，入门费用是泰康之家为确保入住资格而设立的一次性费用，最高可达 20 万元。该费用在客户入住前一次性缴足，用于获取社区的入住权，同时作为履行入住协议的保证金。

最后，月度服务费用涵盖了房屋使用费、居家费用和餐饮费用等，根据客户选择的居住户型和社区的具体位置，月费标准会有所差异。此外，对于需要额外照护服务的客户，如居住在专业护理区的半自理、失能或认知症患者，还需支付相应的分级护理费用。

4.销售模式

泰康之家的销售模式是结合了保险产品与养老服务的创新策略。该模式通过将保险销售与养老服务相结合，形成了独特的市场定位。**泰康之家的市场销售策略专注于高端市场，尤其是在一线城市，旨在提升项目的去化率和入住率。**

泰康之家在销售策略上采用了会员制，客户通过一次性缴纳保费或入门费来获得未来的优先入住资格。对于保险客户而言，他们只需支付月度服务费。而非保险客户则需要缴纳包括乐泰财富卡在内的所有费用，乐泰财富卡是一种传统的“高押金+低月费”模式，为非保险客户提供了一种入住途径。

此外，泰康之家在销售过程中，通常会提前建设并开放生活体验馆，以此来吸引潜在客户并提供直观的社区体验。通过整合保险产品和社区产品的策略，泰康之家不仅提升了保险产品的销售，也为养老社区带来了稳定的客源。同时，泰康之家还利用“名人效应”和针对高净值人群的品牌定位，形成了多头促销的模式，进一步扩大了其在目标市场中的影响力。

5.盈利模式

泰康之家的盈利模式在养老社区领域具有显著特色，实现了资产增值、运营收益、保险销售溢价及床位超卖的“一举四得”。

首先，**泰康之家主要采取长期持有型盈利模式，即通过运营收入和土地、物业增值收益来收回投资并盈利。**与出售型盈利模式不同，长期持有型模式更注重社区的长远发展和持续运营。泰康之家通过向老人提供日常所需的生活照料及医疗护理，以出租方式运营 CCRC，前期投资主要通过房租及后续的运营净资金流来回收。

其次，**泰康之家的收费模式灵活多样，包括“保费/押金+房租+服务费+增值收入”**。这种多元化的收费模式不仅满足了不同老年人的经济能力和服务需求，也为泰康之家带来了稳定的收入来源。

再者，泰康之家在运营管理方面表现出色。根据经验，**当养老社区整体入住率达到约 70%后，运营管理收入便可覆盖运营管理成本，从而产生正现金流。**这表明泰康之家在运营效率和成本控制方面具有较高的水平。

最后，作为重资产模式的代表，泰康之家在前期拿地、建设成本方面具有优势。**这些成本通常不会摊入到运营公司，因此泰康之家在养老社区（CCRC）运**

营方面的收益空间更大。这一优势使得泰康之家能够在激烈的市场竞争中保持稳健的盈利能力。

3.2.3 财务分析

由于泰康健康产业投资控股有限公司并没有公开披露财务信息，因而本部分通过泰康集团公开披露的财务信息中的“利润表-其他业务收入-医疗、养老及纪念园收入”和“利润表-其他业务成本-医疗、养老及纪念园运营成本”两项指标来大致反映泰康之家的盈利情况。具体数据如下图所示。

可以看到，整体盈利状况向好发展。具体来看，2017 年 2020 年医疗、养老及纪念园收入低于成本，其余年份收入均高于成本且 2022 年盈利情况达到峰值——收入 52.64 亿元，成本 36.33 亿元，成本费用利润率为 45%。泰康之家的盈利状况也体现了养老地产行业回报周期长、回报缓慢的特点。

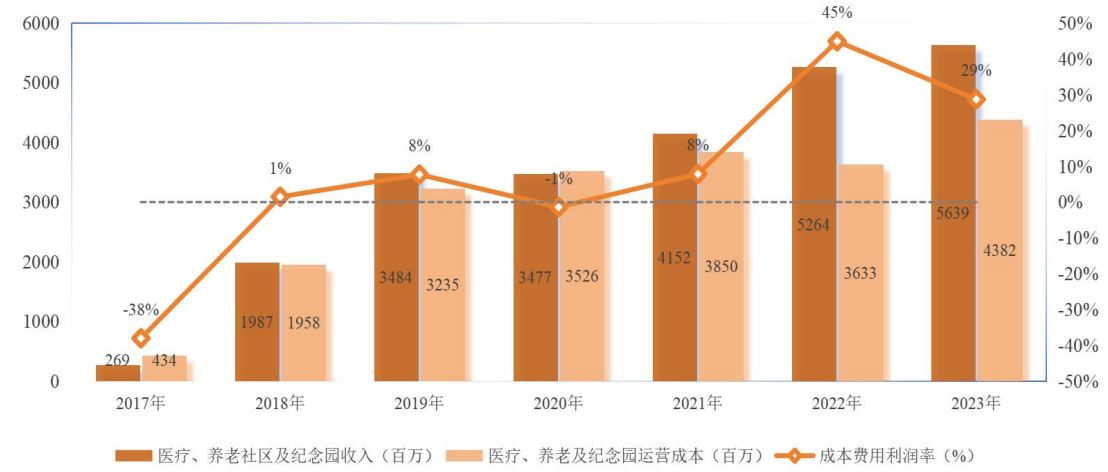


图 63 泰康集团医疗、养老社区及纪念园收入/成本分析

数据来源：泰康集团公开披露的财务信息

注：成本费用利润率=（养老及纪念园收入-养老及纪念园运营成本）/养老及纪念园运营成本*100%

3.2.4 SWOT 综合分析



图 64 泰康之家的 SWOT 分析

来源：团队成员整理

（1）优势分析

1.资源整合能力强——自建医疗健康集团，泰康领跑规模效应

尽管众多大中型保险公司纷纷涉足养老领域，但养老社区的建设与运营面临诸多挑战。重资产投资模式资金门槛高、周期长，跨专业资源的整合难度极大；中资产租赁模式面临物业获取困难、租金竞争力不足以及综合坪效低下的问题；轻资产模式与专业养老服务商的合作却存在诸多不稳定因素。**泰康保险集团则通过自建医疗健康养老生态体系，先行探索并成功构建了难以复制的竞争优势。**其旗下的泰康之家、泰康医疗、泰康拜博口腔以及武汉大学泰康生命医学中心等，共同构成了医养康宁全方位的服务能力，成为泰康的核心竞争力。

2.“支付/负债+医养康宁服务+投资”三端发力

泰康通过构建“支付/负债+医养康宁服务+投资”的三维驱动模式，实现了保险业务从产品导向向服务导向的深刻转型。这一模式的核心在于，泰康自建医疗养老服务集团，创新性地引入了场景化的体验式营销策略，使得潜在客户能够

在购买保险产品前，亲身体验泰康所提供的养老与健康生活方式。这一转变不仅打破了传统保险合同中客户与保险公司之间难以触及的隔阂，还通过增强服务的可接触性、可体验性和可感知性，有效解决了保险产品因虚拟性、射幸性、低互动频率等特性所带来的销售难题。

在资产负债架构的重构方面，泰康巧妙地将寿险支付与医养服务相结合。具体而言，通过“幸福有约”产品，泰康将保费转化为负债，并引导这部分资金进入投资端，用于养老社区与医院的实体建设。客户在保单到期后，可选择按月领取保险金以支付养老费用，而剩余资金则继续在账户内复利增值，从而显著延长了负债端的久期，不仅改变了传统负债端的结构，为投资端提供了更为长期稳定的资本来源，还有助于泰康更好地应对权益投资的经济周期波动性，实现稳定的投资收益。

此外，泰康的这一模式还产生了显著的乘数效应和协同价值效应。高品质的养老社区满足了中高净值人群对未来幸福养老生活的需求，每一张养老床位都能支撑多张“幸福有约”保单的销售，从而形成了服务端对支付端的强大拉动作用。这种保单超售现象为养老社区的重资产投资提供了稳健的自有资金池，增强了泰康在市场上的差异化竞争优势。

从权益投资的角度来看，泰康将原本惯于投向不动产的险资，聚焦于通过长期持有运营可实现稳定回报的养老社区和医院资产。这一投资选择不仅与保险资金的长期性高度匹配，还能有效抵御利率下行风险。同时，由于医养资产的客群收入和成熟期入住率均保持稳定，不受经济周期波动的影响，因此具有穿越周期的抗风险性。未来，泰康可通过资产证券化等多元金融方式实现经营利润率的提升，进一步巩固其在养老健康领域的领先地位。

3.最大化协同的内部治理结构

其内部治理结构实现了产品、服务与销售的深度整合，成功构建了企业内部的“闭环生态系统”，显著提升了运营效率。

以泰康之家·大清谷、泰康之家·燕园等项目为例，养老社区的销售人员不仅能够有效地将客户的关注点引导至保险财富规划与养老服务的结合上，还能顺畅地引入保险销售团队进行现场对接，不仅提升了客户体验，也促进了销售转化率的提高。进一步地，泰康的保险销售人员对集团的资管业务有着深入的了解，

能够清晰地阐述泰康资管的投资板块、投研体系及投资能力，从而增强了客户对泰康整体实力的信任。同时，资管等投资部门在介绍所投资的医疗健康领域时，同样展现出高度的专业性和自信，使得“泰康养老”成为了客户的首选。泰康的这种内部治理结构，实现了支付、服务、投资三个板块的紧密联动，共同遵循着一致的战略导向，实现了资源的有效共享和考评机制的互联互通。

4. 自建运营模式初具规模：以“共和国建设者之家”为标签的社区运营

泰康之家运营的亮点——“共和国建设者之家”，不仅是一个标签，更是一种理念，旨在吸引并汇聚高级知识分子和专业人士，如知名专家、科学家、院士、大学领导、艺术家及企业高管等，从而提升社区的整体文化品位，为社交活动和文化交流提供丰富的资源。泰康之家采用会员制和非保险客户的“乐泰卡”模式，通过前置预售和整合优势，树立“高知、高管、高干”的高净值人群品牌定位，形成多头促销。

（2）机会分析

1. 政策支持：泰康之家发展的机会与优势之源

首先，国家高度重视银发经济的发展，并将其视为应对人口老龄化、扩大内需、推动高质量发展的国家战略的关键实践。其次，政策鼓励医养结合，泰康之家正是这一政策的积极响应者，不仅符合当前政策对养老服务的导向，也有效解决了老年人在养老和医疗方面的双重需求。

此外，泰康之家还享受到了政府在推动智慧养老产业发展方面的政策支持。政策文件明确要求推进新一代信息技术在机构养老等场景集成应用，鼓励利用虚拟现实等技术开展老年用品和服务展示体验。泰康之家积极探索智慧医养实践，通过数据驱动和信息化、数字化、智慧化手段为支撑，打造智慧养老服务体系，这也得到了政策的积极支持。

2. 庞大的高净值客户基础与创新的医养康宁服务场景

根据公开数据的统计结果，截至 2023 年，泰康之家的幸福有约客户数量已超过 20 万人，销售实现量达到 4.6 万单，成功实现了 20 个园区的运营，并有超过万名长者入住，其中居民的平均年龄为 81 岁。这一数据反映了泰康之家在养老服务领域内的显著成就。值得注意的是，泰康之家的居民来源呈现多元化特点，一半来自于保险的行权客户，另一半则来自社会化非保险客户。这种客户结构的

多元化为泰康之家提供了稳定且庞大的高净值客户基础。随着梯度行权的实施，泰康之家能够持续吸引并维护这一优质客户群体，相较于其他非保险背景的高端养老项目，其客户基础优势尤为突出。

在服务模式上，泰康之家医养融合模式，使居民能够同时享受到泰康大健康产业生态体系内的全国优质医疗资源，不仅提升了居民的医疗保障水平，也进一步巩固了泰康之家在养老服务市场的领先地位。此外，泰康之家还构建了医康养宁服务平台，并注重多学科与人才体系的建设。

3. 重资产与轻资产服务的完美融合

泰康养老社区以其独特的运营模式，成功地将重资产投入与轻资产服务相结合，为长者提供了全方位养老环境。

在硬件配套方面，泰康养老社区实现了“温馨的家”、“优雅的俱乐部”、“开放的老年大学”、“高端的医疗保健中心”、“精神家园”五位一体的生活方式。在软件服务方面，泰康养老社区全面满足了长者的“营养美食”、 “医疗保健”、 “活动健身”等七大退休需求，为长者提供了有尊严、有品质、有温度的养老生活。

4. 泰康之家养老项目拓展的标准化与多元化

从项目拓展节奏来看，泰康之家成功实现了“从 0-1-N”的标准化之路。通过拿地重资产投入的方式，泰康之家自 2015 年起迅速布局全国，近九年间已覆盖 35 个城市，年均拓展 3-4 个城市，这一速度在险资企业和养老行业中均处于领先地位。随着重点城市“从 0-1”的项目拓展完成，泰康之家开始探索“从 1-N”的深化布局，于 2021 年采取“两条腿走路”的策略，一方面继续在新兴重点城市进行拓展，另一方面在单一城市内实施“网格化”布局，旨在增加项目密度与丰富度。目前，泰康之家已在上海、北京、成都等地布局了 4 个“府”系产品，标志着其项目拓展进入新阶段。

其次，从项目布局位置来看，泰康之家经历了“从郊区向城心”的拓展转变。以泰康之家燕园为起点，泰康之家摸索出了一套“环城区、重资产、CCRC 社区、医养结合”的标准化复制模式，并以此为基础开启全国拓展。

再者，从项目类型来看，泰康之家成功构建了“园+府”两大系列产品，并正在打造北京和平府项目，作为其首个公建民营项目，标志着泰康之家在投资模

式和项目类型上的双重创新。和平府项目挂牌“和平里街道养老照料中心”，不仅实现了投资模式从重到轻的转换，也是项目类型从 CCRC 向 CB 的延伸，体现了泰康之家多年养老服务经验的积累与升华。

5. 保险业投资养老产业：泰康的双重效益机会优势

首先，作为一家拥有庞大寿险客户群体的保险机构，泰康具备深厚的客户基础。这些客户不仅拥有一定的闲置资金，而且对于养老服务和保险产品有着潜在的需求。泰康通过开发 CCRC 项目，能够有效地回笼已有的客户群，进一步拓展保险业务，从而实现了客户资源的深度挖掘和价值最大化。

其次，通过学习美国先进的养老服务模式，泰康将 CCRC 项目定位于中高端人群，不仅能够提升品牌的吸引力，还能够树立良好的企业形象，使得泰康在养老服务领域形成了差异化竞争优势。

6. 老年人需求井喷：泰康之家的发展新机遇与优势

在人口老龄化的背景下，老年人对于高品质养老服务的需求日益旺盛，这为泰康之家的发展提供了另一大机会优势。随着生活水平的提高和观念的转变，越来越多的老年人开始追求高品质、个性化、全方位的养老服务。泰康之家 “共和国建设者之家”品牌标签，吸引了大量高级知识分子和专业人士入住，满足了老年人对于高品质生活的追求。

（3）劣势分析

1. 定位中高端，收费较高

泰康之家养老社区的定位主要面向中高端市场，其服务品质和设施标准都相对较高，因此收费也相对较高。以泰康之家·上海申园社区为例，单间月费约 9500 元，两居室月费约 16000 元，这些费用一般包括基本居住费用和三餐费用。此外，泰康之家还要求购买一张可退还的会员卡，费用在入住前必须一次性支付，这也增加了入住的经济门槛。

较高的收费标准使得泰康之家在吸引潜在客户时面临一定的挑战。一方面，部分老年人可能因经济原因无法承担如此高的费用；另一方面，一些老年人可能更倾向于选择价格更为亲民、服务基本满足需求的传统养老机构。因此，泰康之家需要在保持服务品质的同时，探索更为灵活多样的收费模式。

2. 前期资金投入量大，收益较慢

泰康之家养老社区的建设和运营需要大量的前期资金投入，包括土地购置、设施建设、人员招聘和培训等方面的费用。然而，由于养老社区的建设周期较长，且需要经历一定的市场培育期才能逐渐实现盈利，因此泰康之家在前期可能面临较大的资金压力。

以泰康保险集团在养老社区业务上的投入为例，数据显示，在 2017 年至 2021 年期间，公司的医疗及养老社区的运营成本投入分别为 4.34 亿元、19.58 亿元、32.35 亿元、33.97 亿元及 36.91 亿元。然而，同期这项业务实现的收入却仅为 2.69 亿元、19.87 亿元、34.84 亿元、33.39 亿元及 39.69 亿元。虽然到后期的成本投入与收入已经无限接近，但收入的体量依旧无法覆盖住成本支出的体量，一直挣扎在亏损的水平线上。这也说明泰康之家在养老社区业务上需要较长的时间才能实现盈利。

3. 缺乏建设和运营经验

养老社区的建设和运营是一个相对复杂的领域，需要专业的知识和技能。然而，泰康之家作为泰康保险集团旗下的新兴业务，在养老社区的建设和运营方面可能缺乏足够的经验和专业知识。例如，在养老社区的建设过程中，泰康之家需要考虑到老年人的特殊需求，如无障碍设施、安全防护措施等。如果缺乏相关经验，可能会导致建设过程中的疏漏或不足。

（4）挑战分析

1. 政策法规不健全

当前养老产业的政策法规体系尚不健全，存在诸多模糊和不完善之处。例如，安宁疗护的体系建设、政策建设以及标准化建设都需要进一步落地，目前仍没有统一的安宁疗护病房建设标准，一些疗愈举措是否能采用也比较模糊。政策法规的不健全可能导致泰康之家在发展过程中遇到法律风险和合规问题，增加了其运营的不确定性和成本。

2. 养老观念有待更新

泰康之家提供的高品质养老服务虽然符合现代老年人的需求，但部分老年人及其家属对养老社区的认知和接受程度仍然有限。他们可能对养老社区的服务质量、安全性以及费用等方面存在疑虑，导致对养老社区的信任度不足。因此，泰

康之家需要积极推广现代养老观念，提高老年人及其家属对养老社区的认知和接受程度。

3. 市场竞争压力大

养老产业是一个快速发展的市场，吸引了众多企业和资本的关注。随着市场竞争的加剧，泰康之家面临着来自其他养老机构和保险公司的竞争压力。这些竞争对手可能在价格、服务品质、品牌影响力等方面具有优势，对泰康之家的市场份额和盈利能力构成威胁。

四、实证分析

4.1 老年人机构养老方式选择的影响因素

当前，家庭规模日益小型化、核心化，家庭养老的社会基础和文化基础被动摇。在社会化养老服务体系的过程中，机构养老被赋予满足老年人养老服务需求的重要任务。然而，老年人内部具有较大的异质性，其养老方式的选择也存在差异，机构养老能否得到老年人的青睐与选择尚不得知。在此情况下，探讨老年人对机构养老的意愿及其影响因素是合理布局养老服务规划、推动机构养老发展的重要依据。基于此，本部分利用 2018 年中国老龄人口健康状况调查（CLHLS）数据，探究机构养老方式选择的影响因素，以期推动我国机构养老服务业的发展和完善。

4.1.1 数据来源

本文的数据来源于中国老龄人口健康状况调查（CLHLS）数据，该数据是由北京大学中国经济研究中心、北京大学老龄健康与家庭研究中心以及美国杜克大学联合开展的一项大规模调查，主要对全国 23 个省市区 65 岁及以上的居民展开调查。本文使用 CLHLS2018 年数据，得到包含 15874 个观测值的有效样本。

4.1.2 数据描述

本文的因变量是老年人机构养老行为和意愿。本文根据调查题项“您现在与谁住在一起”和“您希望哪一种居住方式”分别构建机构养老行为和机构养老意愿变量，将回答为“养老机构”的样本赋值为 1，否则赋值为 0。

根据现有养老相关文献和 CLHLS 数据的可获得性，本文从个体特征、家庭特征和城市特征 3 个层面，选取了年龄、婚姻状况、日常活动有困难数量、家庭人均收入水平、健在子女数、是否参保养老保险、所在城市每千人床位数等 16 个自变量。

表 14 变量的定义与描述性统计

	变量	变量定义	观测值	平均值	标准差	最小值	最大值
因变量	机构养老行为	1=居住在养老机构；0=与家人一起居住或独居	15,548	0.0369	0.189	0	1
	机构养老意愿	1=希望居住在敬老院、老年公寓或福利院；0=独居或与子女一起居住	14,638	0.0247	0.155	0	1
个体特征	性别	1=男；0=女	15,874	0.436	0.496	0	1
	年龄	老人年龄	15,866	85.46	11.70	50	117
	婚姻状况	1=已婚；0=离婚、丧偶或从未结婚	15,607	0.411	0.492	0	1
	户口	1=城镇户口；0=农村户口	15,720	0.275	0.447	0	1
	教育水平	1=未上过学；2=小学及以下；3=初中及以下；4=高中及以下；5=大学及以上	13,498	1.636	0.801	1	5
	是否参加养老保险	1=参保；0=未参保	12,718	0.350	0.477	0	1
	自评健康状况	1=健康；0=不健康	14,442	0.470	0.499	0	1
	日常活动有困难数量		15,757	0.812	1.675	0	6
家庭特征	家庭人均收入	1=家庭人均收入高于中位数；0=家庭人均收入低于中位数	14,349	0.554	0.497	0	1
	健在子女数	健在的子女数量	15,246	3.510	1.664	0	10
城市特征	人均地区生产总值（万元）	所在城市的人均地区生产总值（万元）	14,705	10.57	34.45	1.829	642.2
	人均财政支出（万元/人）	所在城市的人均财政支出（万元/人）	15,422	1.365	1.226	0.405	5.187
	千人床位数	所在城市每千人床位数	14,496	4.694	2.248	0.424	13.77
	千人医生数	所在城市每千人医生数	14,481	2.565	1.649	0.287	6.948

4.1.3 研究方法和模型设定

探究老年人机构养老行为和意愿的影响因素，由于因变量机构养老行为和机构养老意愿均为二值变量，因此本研究采用二元 Logistic 模型进行实证分析，模型设定如下：

$$P(y=1)=\frac{e^{z}}{1+e^{z}} \quad z=\beta_0+\sum_{i=1}^{n}\beta_i X_i \qquad (1)$$

式（1）中，z 表示老年人在养老机构居住或希望在养老机构居住的概率比，X_i表示性别、年龄、婚姻状况、日常活动有困难数量、是否参加养老保险等自变量，β_0代表常数项。β_i为本部分中重点关注的系数，表示变量对老年人机构养老行为或意愿的影响程度。

4.1.4 实证结果及分析

回归结果如表 16 所示。模型 1 检验了家庭人均收入对老年人机构养老行为的影响。结果表明，高家庭人均收入显著地促进老年人机构养老的行为。模型 2 加入其他一系列控制变量显示，家庭人均收入对老年人机构养老行为仍然具有显著的正向影响，即高家庭人均收入的老年人居住在养老机构的概率比低家庭人均收入的老年人高 4.1%。婚姻状况对老年人机构养老行为具有显著的负向影响，即丧偶或未婚老年人更有可能居住在养老机构。城镇老年人比农村老年人居住在养老机构的概率显著高 0.9%；日常活动有困难数量每增加 1 个，老年人居住在养老机构的概率显著增加 0.6%。

模型 5 考察了家庭人均收入对老年人机构养老意愿的影响。结果表明，家庭人均收入对老年人机构养老意愿存在显著正向影响。模型 6 加入了其他一系列控制变量显示，家庭人均收入对老年人机构养老意愿仍然存在显著的正向的影响，即相较于低家庭人均收入的老年人，经济水平较高的老年人机构养老意愿高 1.6%。控制变量中，已婚老年人的机构养老意愿比丧偶或未婚老年人显著低 1.7%；健在子女数量每增加 1 个，老年人选择机构养老会显著减少 0.1%。而自评健康状况更差、日常活动有困难数量的老年人选择机构养老的意愿越高。此外，教育水平对老年人机构养老意愿也呈现显著的正向影响。

这一结果的可能解释是，**高经济收入水平的老年人更有能力负担较高昂的机构养老支出；丧偶或未婚老年人、健在子女数量少的老年人由于缺乏家人的照顾和支持，因而更倾向于选择机构养老服务；相较于农村老人，城镇老人的养老机构可及性更高，因此更有可能机构养老；养老机构可以提供专业的生活照料和医疗护理服务，因而健康状况较差、失能或半失能老年人选择居住或希望居住在养老机构。**

表 15 实证结果

	模型 1	模型 2		模型 3	模型 4	
	Logistic	Logistic	AME	Logistic	Logistic	AME
变量	机构养老行为	机构养老行为	机构养老行为	机构养老意愿	机构养老意愿	机构养老意愿
家庭人均收入	3. 262***	2. 408***	0. 041***	2. 192***	1. 345***	0. 016***
	(0. 255)	(0. 373)	(0. 007)	(0. 202)	(0. 314)	(0. 004)
性别		0. 021	0. 000		0. 050	0. 001
		(0. 203)	(0. 003)		(0. 241)	(0. 003)
年龄		0. 016	0. 000		0. 005	0. 000
		(0. 011)	(0. 000)		(0. 012)	(0. 000)
婚姻状况		−0. 848***	−0. 014***		−1. 431***	−0. 017***
		(0. 271)	(0. 005)		(0. 329)	(0. 004)
户口		0. 562***	0. 009**		0. 136	0. 002
		(0. 217)	(0. 004)		(0. 281)	(0. 003)
健在子女数		−0. 062	−0. 001		−0. 115*	−0. 001*
		(0. 054)	(0. 001)		(0. 067)	(0. 001)
是否参加养老保险		−0. 096	−0. 002		0. 023	0. 000
		(0. 187)	(0. 003)		(0. 224)	(0. 003)
教育水平		0. 156	0. 003		0. 340**	0. 004**
		(0. 116)	(0. 002)		(0. 136)	(0. 002)
自评健康状况		−0. 149	−0. 003		−0. 485**	−0. 006**
		(0. 181)	(0. 003)		(0. 220)	(0. 003)
日常活动有困难数量		0. 162***	0. 003***		0. 030	0. 000
		(0. 052)	(0. 001)		(0. 073)	(0. 001)
人均地区生产总值（万元）		−0. 003	−0. 000		−0. 032	−0. 000
		(0. 008)	(0. 000)		(0. 044)	(0. 001)
人均财政支出（万元/人）		0. 296***	0. 005***		0. 043	0. 001
		(0. 098)	(0. 002)		(0. 131)	(0. 002)
千人床位数		0. 026	0. 000		0. 001	0. 000
		(0. 079)	(0. 001)		(0. 107)	(0. 001)
千人医生数		0. 065	0. 001		0. 371**	0. 004**
		(0. 118)	(0. 002)		(0. 158)	(0. 002)
观测值	14, 154	7, 739	7739	13, 360	7, 587	7, 587

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%水平上的显著性。

为检验结果的稳健性，本研究将原模型替换为 OLS 模型，分别考察老年人机构养老行为和意愿的影响因素。表 17 中(1)和(2)汇报了 OLS 回归结果，(3)和(4)汇报了 Probit 回归结果。回归结果与原模型基本一致，本文的估计结果是稳健的。

表 16 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
	OLS 模型		Probit 模型	
变量	机构养老行为	机构养老意愿	机构养老行为	机构养老意愿
家庭人均收入	0.021***	0.010***	0.897***	0.478***
	(0.003)	(0.002)	(0.127)	(0.112)
性别	0.000	-0.000	0.010	0.042
	(0.003)	(0.003)	(0.091)	(0.100)
年龄	0.000	0.000	0.009*	0.002
	(0.000)	(0.000)	(0.005)	(0.005)
婚姻状况	-0.010***	-0.014***	-0.350***	-0.538***
	(0.004)	(0.003)	(0.115)	(0.129)
户口	0.019***	0.005	0.240**	0.047
	(0.006)	(0.004)	(0.099)	(0.121)
健在子女数	-0.001	-0.001	-0.024	-0.045*
	(0.001)	(0.001)	(0.024)	(0.027)
是否参加养老保险	-0.001	0.001	-0.038	0.013
	(0.003)	(0.003)	(0.084)	(0.092)
教育水平	0.005	0.008**	0.068	0.134**
	(0.005)	(0.004)	(0.056)	(0.063)
自评健康状况	-0.001	-0.006**	-0.059	-0.197**
	(0.003)	(0.003)	(0.081)	(0.090)
日常活动有困难数量	0.006***	0.001	0.079***	0.012
	(0.002)	(0.001)	(0.024)	(0.031)
人均地区生产总值（万元）	-0.000***	-0.000***	-0.002	-0.017
	(0.000)	(0.000)	(0.005)	(0.018)
人均财政支出（万元/人）	0.026***	0.009**	0.148***	0.020
	(0.006)	(0.004)	(0.048)	(0.058)
千人床位数	-0.003	-0.002	-0.016	-0.013
	(0.002)	(0.002)	(0.037)	(0.045)
千人医生数	-0.001	0.005*	0.062	0.183***
	(0.004)	(0.003)	(0.057)	(0.067)
观测值	7,739	7,587	7,739	7,587
R^2	0.057	0.026		

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%水平上的显著性。

4.1.5 总结与结论

本部分基于 2018 年中国老龄人口健康状况调查（CLHLS）数据，采用 Logistic 模型探讨了个体特征、家庭特征和城市特征对老年人机构养老行为和意愿的影响。研究表明，**高经济收入水平、丧偶或未婚、健康状况差、失能程度高、城镇户口的老人年更有可能产生机构养老的行为和意愿。**这一结论为养老机构确定客户群体画像、明晰业务发展方向提供了参考，有利于推进养老机构的高质量发展。同时，在推动社会化养老体系建设中，政府也应当关注收入水平较低、农村户口的弱势老年人，通过政府购买或补贴为其提供低价或无偿照料服务，缓解弱势老年人入住养老机构的经济和资源压力。

4.2 探究养老机构的价格影响因素

当前商业养老机构发展问题之一为：中高端民营养老机构价格过高，普通家庭难以承担。这直接限制了我国民营养老机构的发展，导致床位空置率较高，缺乏稳定的盈利模式。因此，养老机构的价格影响因素成为我们关注的问题之一。除了已知的经营性质可能会影响养老服务的价格之外，是否还有其他的影响因素。本部分将利用 CnOPenData 数据库提供的全国养老机构数据探究养老机构价格的影响因素。

4.2.1 数据介绍

CnOPenData 是覆盖经济、法律、医疗、人文等多个学科维度的综合型数据平台。该平台的中国养老机构数据来源于养老网的爬虫数据，包含全国 31 个省市在官网公开信息的养老机构。本文使用的数据来源于中国养老机构数据，共计 1500 条，样本包含东中西部的不同性质、不同价格区间、不同类型的养老机构，具有一定的代表性。

4.2.2 数据描述

本部分主要探究的问题是养老机构定价的影响因素，因此我们将收费区间中值作为因变量，选取的自变量则包含是否是 CCRC 机构、所处地区（东部、中部、西部）、是否涉及智慧养老、床位数量、机构性质、是否医保覆盖、能否接受异地老人。其中，机构性质是分类变量，1 代表公办，2 代表公办民营，3 代表民办公助，4 代表民营，1～4 表示商业成分越来越大；医保覆盖和异地接收是

0-1 变量，1 代表“是否被医保覆盖”和“能否接收异地老人”；东部、西部和中部是三个地区虚拟变量。

由表可得，全国各地的养老机构收费区间中位数标准差较大，最小值为 200 元/月，最大值则高至 43567.5 月。CCRC 机构和具备智慧养老的机构在总体中占比较小。

表 17 描述性统计分析

变量名称	数量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
收费区间中值	1500	3138.79	3552.252	0	1900	43567.5
CCRC 模式	1500	0.04	0.198	0	0	1
智慧养老	1500	0.16	0.367	0	0	1
床位数量	1500	195.79	456.481	0	67	12000
性质	1500	2.44	1.414	1	2	4
医保	1500	0.18	0.384	0	0	1
异地	1500	0.37	0.482	0	0	1
东部	1500	0.63	0.483	0	1	1
西部	1500	0.15	0.360	0	0	1
中部	1500	0.22	0.412	0	0	1

4.2.3 相关性分析

由于我们关心的问题是养老机构价格的影响因素，因此在进行回归分析之前，对本部分所有的变量都进行相关性分析。

可以看出，CCRC 机构、智慧养老、床位数量、养老机构性质、医保覆盖、异地接收老人、处于东部地区均与养老机构的收费区间中值呈现显著的正相关关系。而位于西部、位于中部则会与养老机构的收费区间中值显著负相关关系。

表 18 相关性分析

	收费区间中值	CCRC 模式	智慧养老	床位数量	性质	医保	异地	东部	西部	中部
收费区间中值	1									
CCRC 模式	0.287***	1								
智慧养老	0.405***	0.250***	1							
床位数量	0.312***	0.297***	0.238***	1						
性质	0.412***	0.107***	0.222***	0.194***	1					
医保	0.282***	0.123***	0.149***	0.239***	0.333***	1				
异地	0.310***	0.088***	0.216***	0.166***	0.568***	0.560***	1			
东部	0.151***	0.038	0.105***	0.053**	-0.010	0.045*	-0.033	1		
西部	-0.072***	-0.012	-0.044*	-0.029	-0.051*	-0.073***	-0.051**	-0.555***	1	
中部	-0.114***	-0.034	-0.084***	-0.037	0.055**	0.011	0.083***	-0.687***	-0.223***	1

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%水平上的显著性。

4.2.4 养老机构价格影响因素分析

本部分将收费区间中值作为因变量，将 CCRC、智慧养老、床位数量、养老机构性质、医保覆盖、接收异地老人、西部、中部作为自变量利用 OLS 模型进行回归。

CCRC 的回归系数为 2516.669，表明 CCRC 模式会显著影响收费区间中值，养老机构类型为 CCRC，其价格要高于其它类型的养老机构。

智慧养老的回归系数为 2390.885，表明具备智慧养老服务的养老机构收费区间中值要高于其它养老机构。因此，**智慧养老是影响养老机构价格的因素之一。**

养老机构性质也是显著影响养老机构价格的因素之一。随着养老机构的商业性质变强，养老机构的价格也会随之变高。这与上述行业分析、案例分析得出的结论一致，民营养老机构价格要高于公办养老机构。

床位数量也是影响养老机构价格的重要因素之一，且床位数量越多，养老机构价格越高。养老机构的规模在一定程度上也可能影响养老机构的价格。

医保覆盖的养老机构也是影响养老机构价格的因素之一。具备医保资格的养老机构平均意义上比不具备医保资格的养老机构的价格要高 821.256 元。

养老机构所在的地域也是影响养老机构价格的因素之一。与东部地区相比，西部地区的养老机构收费区间中值平均意义上要低 589.539 元；而中部地区的养老机构收费区间中值平均意义上要低 998.118 元。

是否接受异地养老并不能显著影响养老机构收费区间中值。

表 19 回归分析

	(1)
	模型 1
CCRC 模式	2516.669***
	(403.06)
智慧养老	2390.885***
	(218.72)
床位数量	0.983***
	(0.18)
性质	699.969***
	(64.89)
医保	821.256***
	(238.69)
异地	162.770
	(215.38)
西部	-589.539***
	(213.43)
中部	-998.118***
	(187.84)
常数项	847.392***
	(161.31)
N	1500
R^2	0.344
Adj. R^2	0.34

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%水平上的显著性。

4.2.5 总结与结论

本部分利用相关性分析和 OLS 回归模型探究影响养老机构价格的因素。结果表面，养老机构为 CCRC、提供智慧养老服务、增加床位数量、民营机构、具备医保资格、位于东部地区会正向影响养老机构的价格区间中值。但是接受异地老人与养老机构价格区间呈现正相关关系，但是影响并不显著。

五、发展建议与展望

5.1 微观层面

5.1.1 创新融资方式，稳定资金来源

目前，我国大部分养老地产企业融资渠道和融资模式比较单一，无法满足其对资金的需要。因此，未来养老地产企业应积极拓宽融资渠道，通过募集海外资金、地产投资信托基金、资产证券化等方式吸纳外部资金注入，满足开发运营的融资需要。

5.1.2 探索新型经营模式，实现可持续运作

养老地产项目建设前期投资大、运营成本高、资金回流周期相对较长，单一的重资产模式会给养老地产企业带来沉重的财务压力，加大信贷和经营风险。未来养老地产企业应优化开发运营模式，通过小规模连锁化经营，提升对服务环节轻资产运营的关注度，实现品牌和运营模式的输出，降低经营成本，拓宽盈利渠道，增强抵御风险能力。

5.1.3 开发复合产品，提供智能化高质量服务

当前老年人养老服务呈现需求多元化、专业化、高品质特征，养老地产建设和运营主体应当积极拓展业务范围和衍生产业，提供集医疗保健、康复护理、文化娱乐等一体的综合性养老服务和复合型养老产品，布局以养老地产为载体的全面消费产业链，并注重提升产品和服务质量，尤其是日常照料、医疗护理等核心业务，加大对相关工作人员的专业培训力度，进而吸引更多老年人群体消费。同时，养老地产企业可以通过云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，围绕老年人安防、健康、餐饮、照护、社交等核心需求开发数字平台，提高养老服务的供给质量和效率，改善老年人的居住体验。

5.2 中观层面

5.2.1 促进产业融合发展，深化合作关系

与传统住宅地产不同，养老地产的服务延伸至衣食住行、护理、娱乐等多方面消费场景，需要房地产开发商与保险公司、养老服务机构、医疗机构等市场主

体充分发挥各自专业优势，形成良好的融合联动和合作运营格局，尤其是推动医养结合的深入发展。同时，地产商与其他主体之间的合作渠道要从单一的招商引进发展成为双向合作的共建、收购、参股、并购等，充分整合各产业核心优势资源，激发主体发展活力。

5.2.2 细分行业市场，形成多层次布局

根据分析，我国不同特征的老年人群体对养老服务的价格预期、服务内容、服务形式等需求层次也呈现多样化特征。因此，养老地产行业应对市场进行细分，打造多元化产品结构和产业链条，在行业内形成差异化服务供给格局、多区域协调布局，既发展“保基本”的普惠型养老地产，也开发“求品质”的中高端养老地产，充分挖掘不同需求层次的银发市场潜力。

5.3 宏观层面

5.3.1 优化政策环境，刺激行业供需发展

从产品属性上看，广义的“养老产品”具有极强的外部性和准公共物品特征，在目前我国养老地产行业处于供需失衡状态的背景下，政府应当有效利用政策工具，助力市场力量实现养老产品的有效供给，增强社会整体福利。

针对养老地产企业，政府可以适当放宽投信贷融资政策，通过政府养老金或产业基金持有养老 REITs 产品的方式，引导 REITs 养老商业地产的发展模式，缓解企业融资贷款压力。同时，政府可以通过国有土地划拨、税收优惠、减免行政事业性收费等给予开发商支持和优惠政策，降低开发商开发成本，调动市场积极性。

针对老年人群体，政府应当为愿意选择社区机构养老模式的中低收入老年群体提供养老津贴，刺激消费需求。对于依赖专业护理的失能老人，政府应当继续扩大长期护理保险保障内容，加快实现其在全国范围统筹实施，为失能老人选择社区、机构护理提供补贴。

5.3.2 加大监管力度，建设行业标准

目前，我国养老地产市场整体比较混乱，建设标准和市场监督体系尚未健全。因此，政府应当加快制定养老地产行业建设标准、验收标准，完善市场准入制度、违规惩罚措施等；加大对养老地产市场的监管力度，构建政府监管、企业自检、

公众监督的三级监管体系，限制开发商的投机行为，营造良好的市场环境。

5.3.3 积极推广宣传，营造社会化养老氛围

受我国传统文化影响，我国大部分老年人仍更倾向于居家养老，但当前家庭规模小型化、家庭养老功能逐渐弱化，居家养老难以满足老年人的需求。政府应当加大宣传力度，引导居民养老观念转变和对优秀养老地产项目的认可度，营造良好的社会化养老氛围，助力养老地产行业良性可持续发展。

参考文献

（一）学术文章

[1] 傅沂, 李海青. 养老地产开发的进入机制研究——基于 Van Damme 模型的两阶段演化博弈应用[J]. 华东经济管理, 2020, 34(07):98-108.

[2] 高珂, 王涛, 任金凤, 等. 以财政投融资政策促进养老产业发展[J]. 宏观经济管理, 2022, (02):68-75.

[3] 高颖. 银发经济的发展机遇及其布局[J]. 人民论坛, 2024, (10):84-87.

[4] 郭珊珊, 杜进林, 翟方明, 等. 我国养老机构资源配置时空差异分析与优化策略——基于 2014～2021 的国家统计数据[J]. 中国卫生事业管理, 2023, 40(10):754-759.

[5] 金牛, 刘梦琦. 银发经济高质量发展：内涵意蕴、机遇挑战与体系构建[J]. 河北农业大学学报(社会科学版), 2024, 26(03):1-9.

[6] 金牛, 原新. 银发经济高质量发展：人口基础、战略导向与路径选择[J]. 河北学刊, 2024, 44(02):158-166.

[7] 刘宏，高松，王俊. 养老模式对健康的影响[J]. 经济研究, 2011, 46(04):80-93+106.

[8] 刘亮, 郭师虹, 杨晶晶. 我国养老地产发展现状及对策研究[J]. 建筑经济, 2016, 37(01):67-70.

[9] 穆光宗. 银发经济的发展机遇与方向[J]. 人民论坛, 2024, (13):12-16.

[10] 汪竹飞，唐晓莲. 国内外养老地产发展文献综述[J]. 改革与战略, 2014, 30(05):24-26+74.

[11] 王璐. 发展银发经济应对人口老龄化[N]. 金融时报, 2024-08-12(008).

[12] 王旭育. 基于社区模式的美国养老地产发展研究与启示[J]. 城市发展研究, 2016, 23(05):119-124.

[13] 张争艳, 王化波. 珠海市老年人口养老意愿及影响因素分析[J]. 人口学刊, 2016, 38(01):88-94.

（二）行研报告

[1] 大家保险 《2023 年中国商业养老服务供需洞察白皮书》

[2] 海通国际 《养老地产系列研究（1）：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红》

[3] 平安证券 《养老地产行业全景图——“需求升级+政策红利”双轮驱动，养老地产有望开启新时代》

[4] 前瞻产业研究院 《中国养老地产产业全景图谱》

（三）政策文件

[1] 2024 年，国务院办公厅《发展银发经济增进老年人福祉的意见》

[2] 2024 年，民政部、全国老龄办《2023 年度国家老龄事业发展公报》

[3] 2023 年，民政部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、应急管理部 、税务总局、市场监管总局联合发布《积极发展老年助餐服务行动方案》

[4] 2023 年，世界卫生组织（WHO）《2022 年世界卫生统计报告》

[5] 2023 年，中华人民共和国国家卫生健康委员会《2022 中国卫生健康统计年鉴》

[6] 2022 年，规划发展与信息化司《2021 年我国卫生健康事业发展统计公报》

[7] 2022 年，国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务事业规划》

[8] 2021 年，国家发改委《第十四个五年规划纲要和 2035 年远景目标纲要》

[9] 2021 年，国务院关于“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知

[10] 2021 年，国务院《2020 年第七次人口普查数据》

[11] 2019 年，国务院《国家积极应对人口老龄化中长期规划》

[12] 2019 年，民政部《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》

[13] 2019 年，自然资源部《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》

[14] 2019 年，发展改革委、民政部、卫生健康委联合发布《城企联动普惠养老专项行动实施方案(试行)》